

胃腫瘍

消化器内科

田中 守

胃腫瘍

上皮性

- 胃癌
- 胃ポリープ[○]
 1. 胃腺腫、
 2. 過形成性ポリープ、
 3. 胃底腺ポリープ

非上皮性

- 胃悪性リンパ腫
- GIST (gastrointestinal stromal tumor)

医師国家試験過去問 1

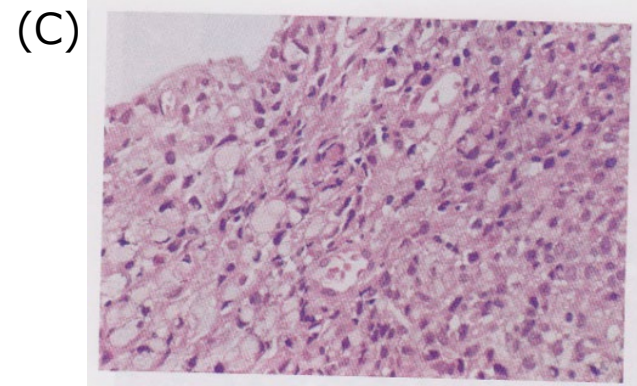
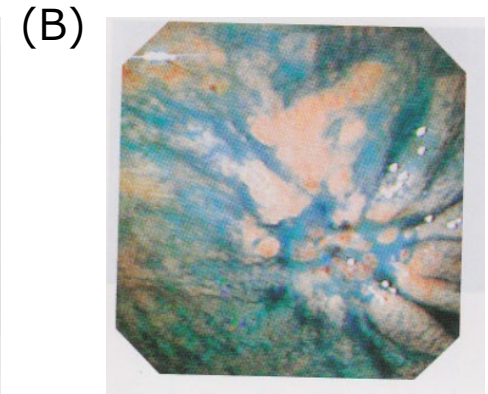
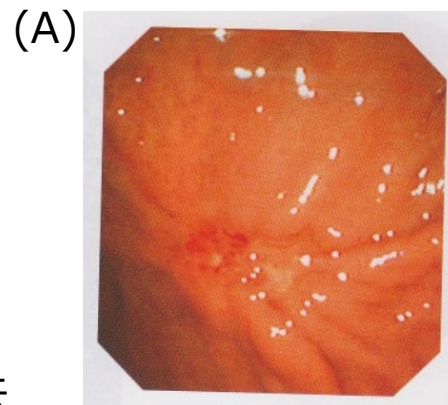
早期胃癌に関連して正しいのはどれか。2つ選べ。

- a 癌浸潤が粘膜下層までにとどまる。
- b 浸潤型は直径2cm以上にならない。
- c II c型が最も多い。
- d II a型の表面色調は蒼白のことが多い。
- e リンパ節転移はない。

医師国家試験過去問 2

57歳の男性。胃のもたれ感を訴えて来院した。胃内視鏡検査を行った。インジゴカルミン色素散布前後の胃内視鏡写真(A,B)と生検組織H-E染色標本(C)とを別に示す。適切な治療法はどれか。

- a 消化酵素薬投与
- b 胃粘膜保護薬投与
- c ヒスタミンH2受容体拮抗薬投与
- d ヘリコバクター・ピロリ除菌療法
- e 胃切除術



医師国家試験過去問 3

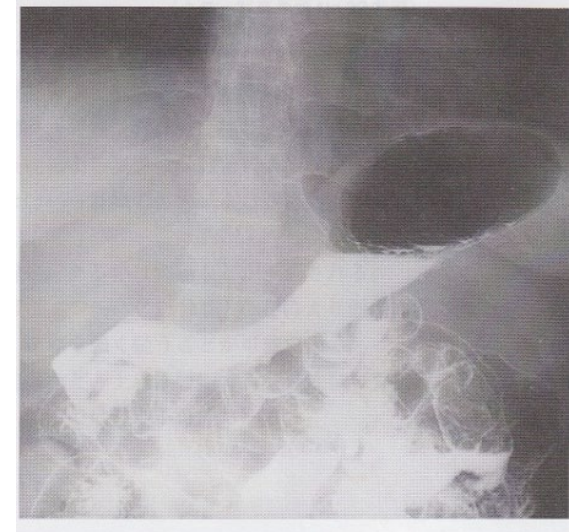
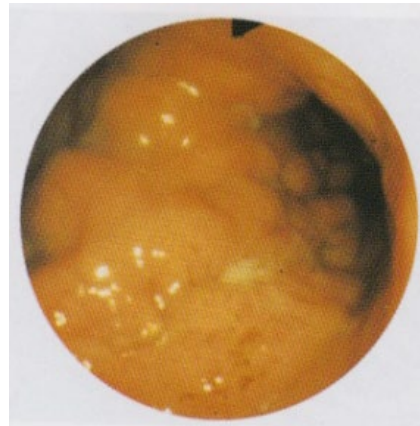
胃癌について正しいのはどれか。2つ選べ。

- a 年齢調節死亡率は増加している。
- b スキルス癌は高齢者に多い。
- c 早期癌とは深達度が粘膜下層まででリンパ節転移のないものをいう。
- d 左鎖骨上窩リンパ節に転移する。
- e 再発形式で最も多いのは腹膜播種性転移である。

医師国家試験過去問 4

48歳の女性。2か月前から腹痛と腹部膨満感とが出現し、背部痛を伴ってきたので来院した。腹部超音波検査で両側の卵巣に腫瘍像を認めた。赤血球306万、Hb11.0g/dl、白血球4700、血小板3.2万。血清生化学所見：AST33IU/l、ALT19IU/l、LDH521IU/l（正常370以下）、プロトロンビン時間18秒（正常10～14）、血漿フィブリノゲン100mg/dl（正常170～410）。赤沈3mm/1時間。胃内視鏡写真と胃エックス線造影検査とを別に示す。
この患者について考えられるのはどれか。

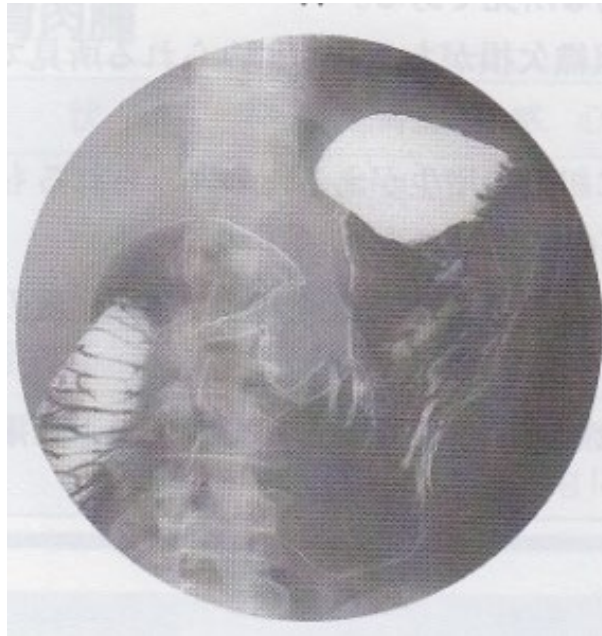
- (1)カルチノイド症候群
- (2)paraneoplastic syndrome
- (3)播種性血管内凝固症候群(DIC)
- (4)Krukenberg腫瘍
- (5)Meigs症候群



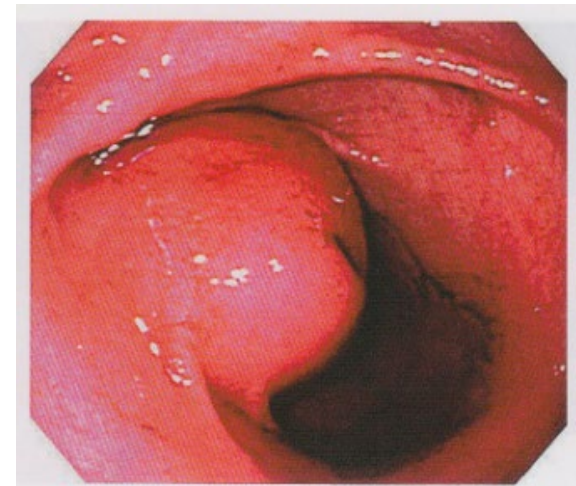
医師国家試験過去問 5

45歳の女性。上腹部不快感を訴えて来院した。最近3カ月で2kgの体重減少がある。身長154cm、体重43kg。表在リンパ節は触知しない。眼瞼結膜に軽度貧血を認める。心窩部に軽度の圧痛がある。血液所見：赤血球340万、Hb11.4g/dl、Ht33%、白血球4500、血小板21万。上部消化管造影写真(A)と胃内視鏡写真(B)とを別に示す。最も考えられるのはどれか。

(A)



(B)



- a 急性胃炎
- b 胃潰瘍
- c II c型早期胃癌
- d 4型進行胃癌
- e 胃肉腫

医師国家試験過去問 6

早期胃癌の肉眼型で発生頻度の最も高いにはどれか。1つ選べ。

- a I 型
- b II a 型
- c II b 型
- d II c 型
- e III 型

胃腫瘍

上皮性

- 胃癌

- 胃ポリープ

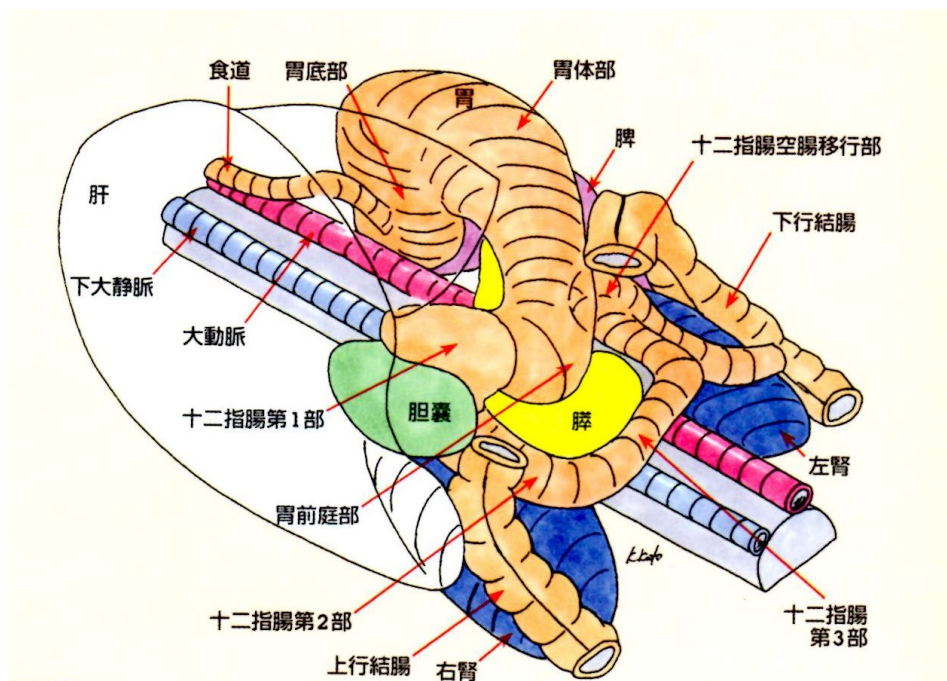
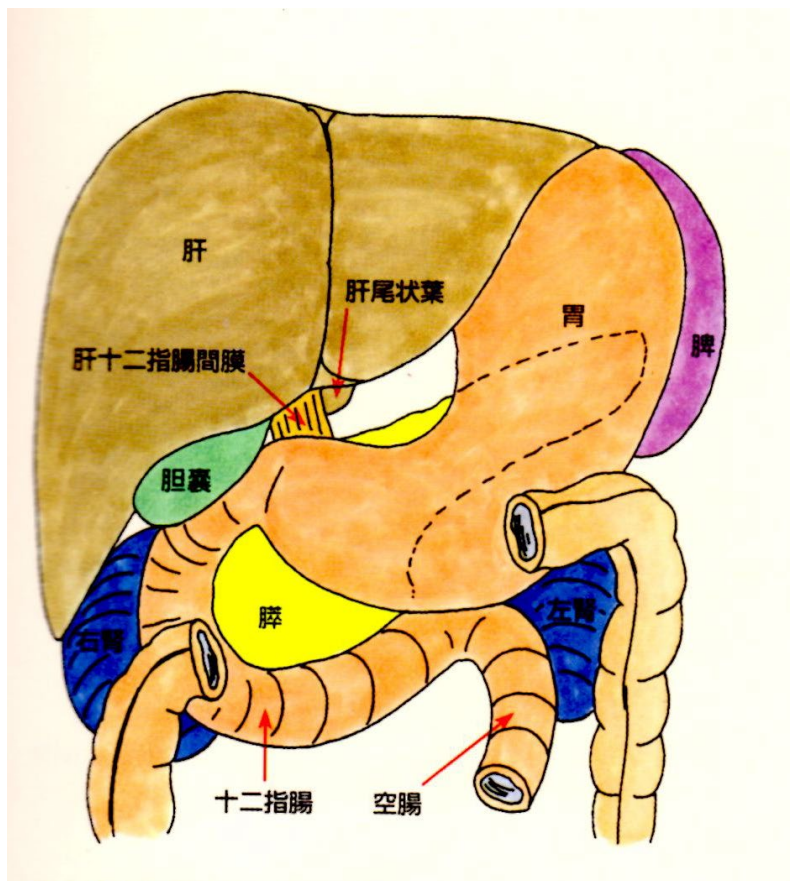
1. 胃腺腫、2. 過形成性ポリープ、3. 胃底腺ポリープ

非上皮性

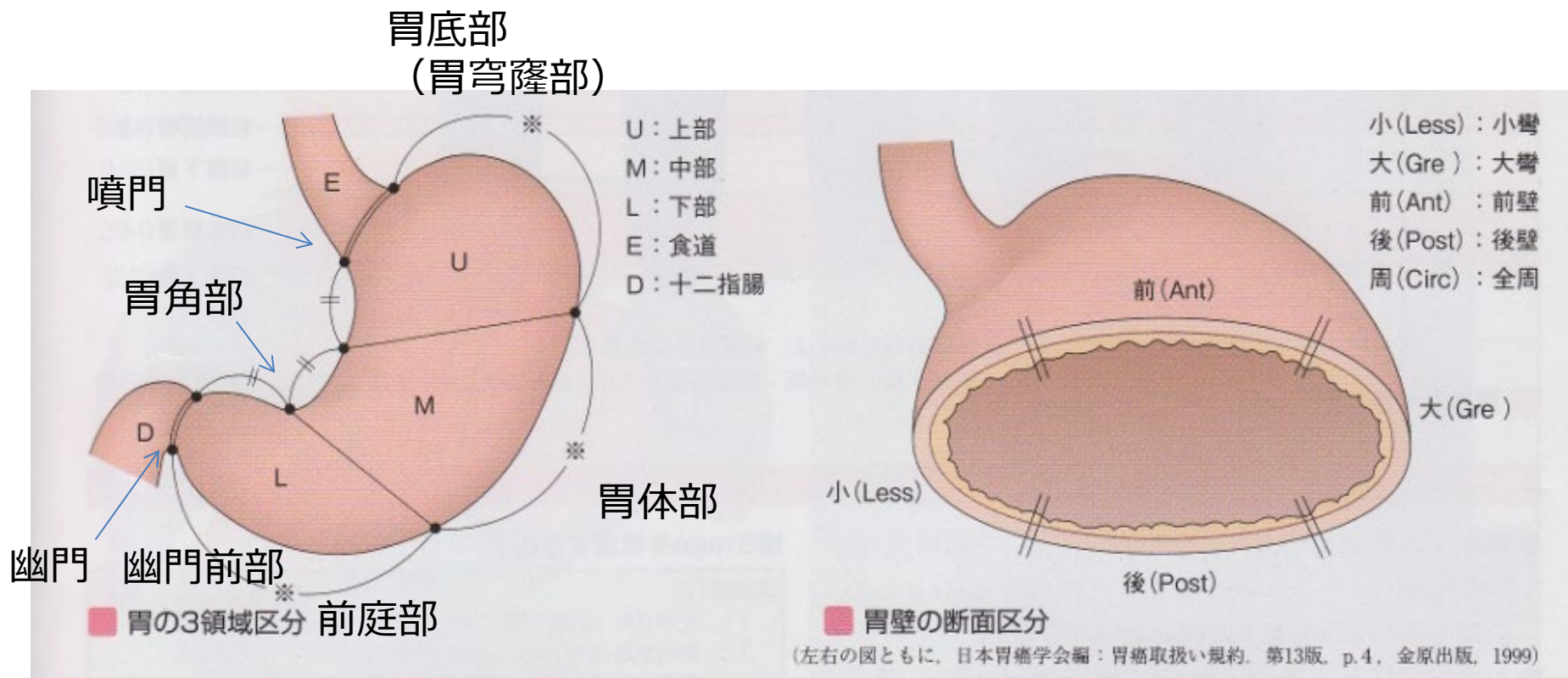
- 胃悪性リンパ腫

- GIST (gastrointestinal stromal tumor)

胃の解剖



胃の解剖

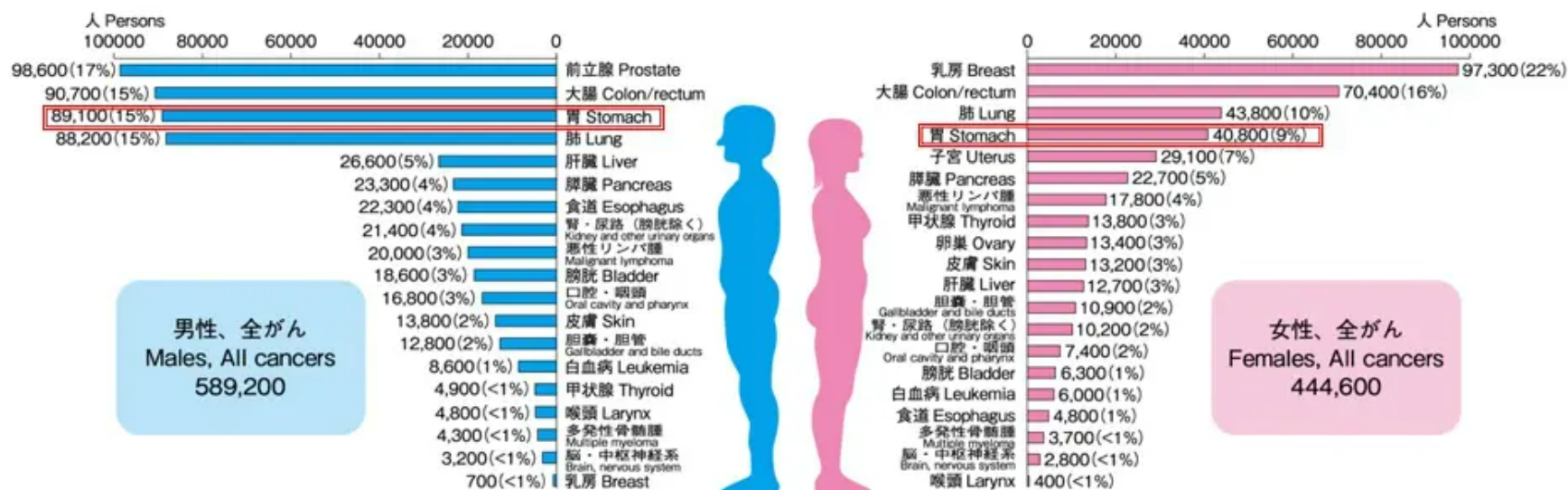


胃癌 基本事項

- 大部分が**腺癌**
- 日本での死亡数は肺癌、大腸癌について3位
- 胃癌による死亡率は減少傾向
- 危険因子は*Helicobacter pylori*、食塩、喫煙、EBウイルス（HP陰性胃癌は0.4～0.7%程度）
- 胃前庭部には腸上皮化生を背景に**分化型腺癌**が多い。胃体部には胃底腺から発生する**未分化型腺癌**が多い

部位別予測がん罹患数（2023年）

Projected Number of Cancer Incidence by Site (2023)



がんの統計2024

胃癌は男性3位、女性4位の罹患者数

日本における癌死の内訳（2023）

	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位
男女計	肺	大腸	膵臓	胃	肝臓
男性	肺	大腸	胃	膵臓	肝臓
女性	大腸	肺	膵臓	乳房	胃

Cancer Statistics. Cancer Information Service, National Cancer Center, Japan
(Vital Statistics of Japan, Ministry of Health, Labour and Welfare)

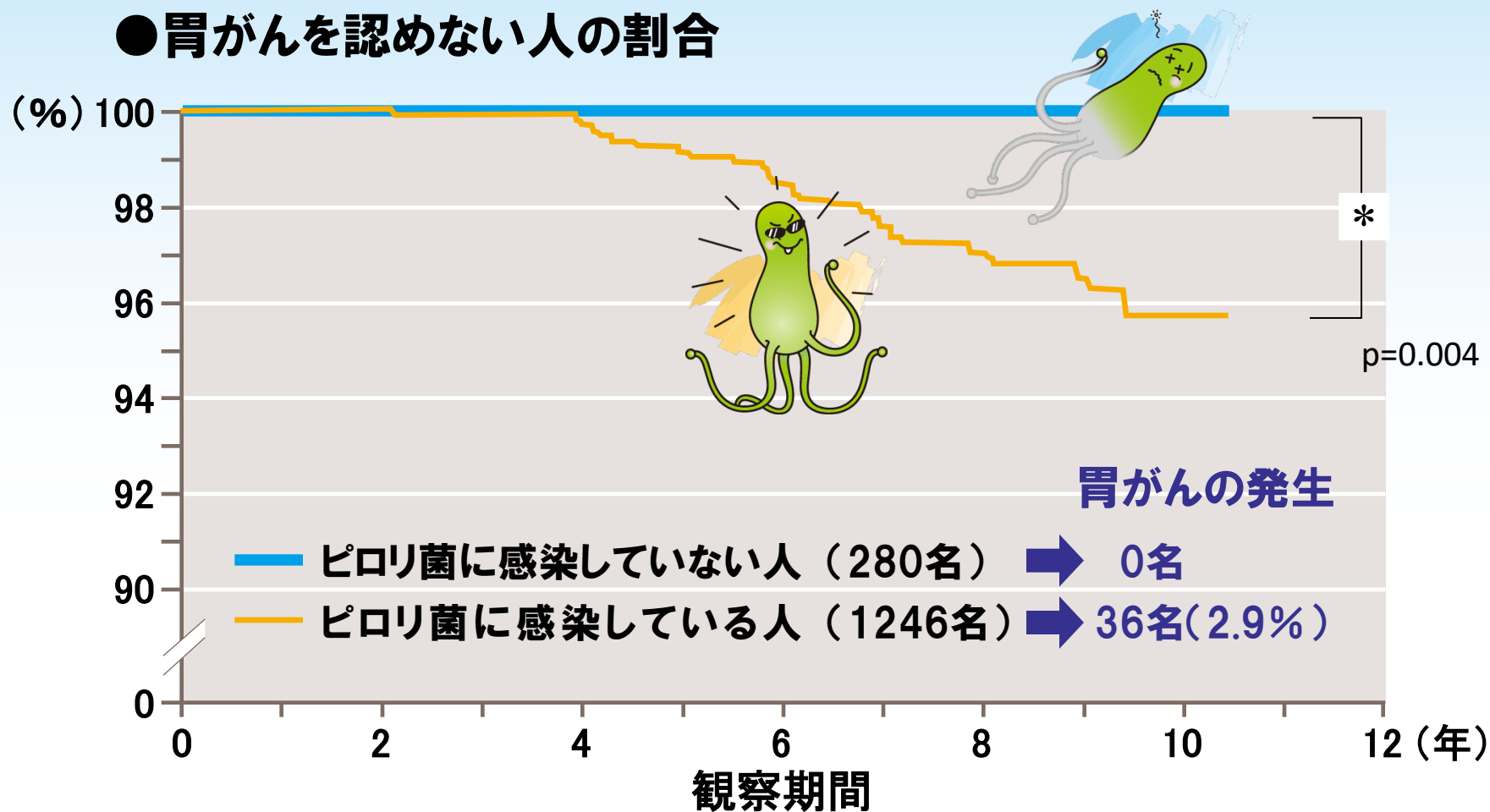
*Helicobacter pylori*と胃癌

- *H.pylori*は確実な癌原性因子
- 日本人の約35%が*H.pylori*に感染
- 全ての*H.pylori*感染者が胃癌になるわけではない
- 他のアジア諸国において*H.pylori*感染率が高いのに胃癌は低率の国もあることから宿主要因や菌自体の毒性、食習慣など様々な要因が関係していると考えられる

ピロリ菌と胃がんの関係!?

ピロリ菌に感染している人と感染していない人に対して10年間の調査を行ったところ、感染している人では2.9%に胃がんが発見され、感染していない人では胃がんは認められなかったという報告があります。

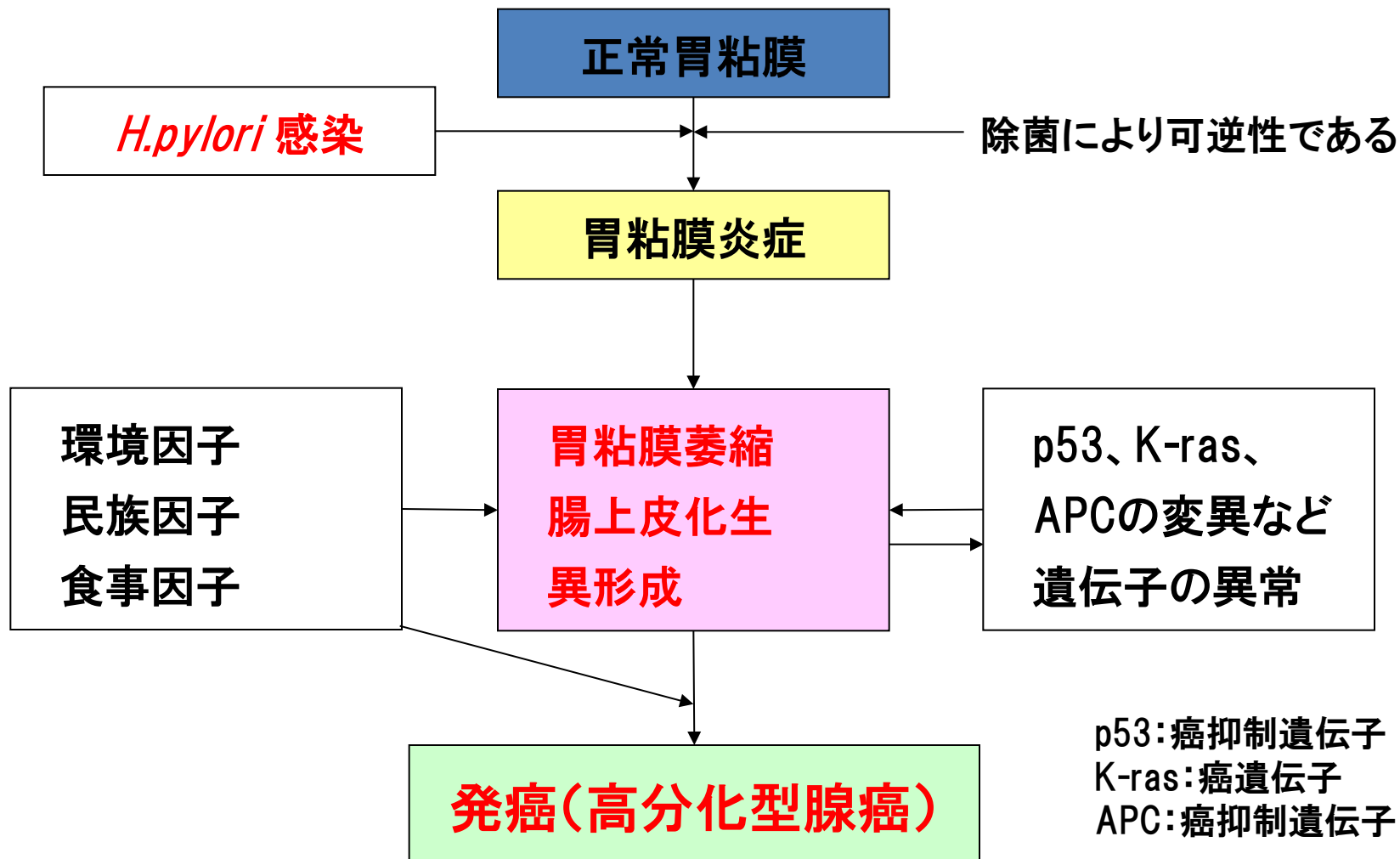
●胃がんを認めない人の割合



▶ ナポレオンの死因は胃がんだった!?

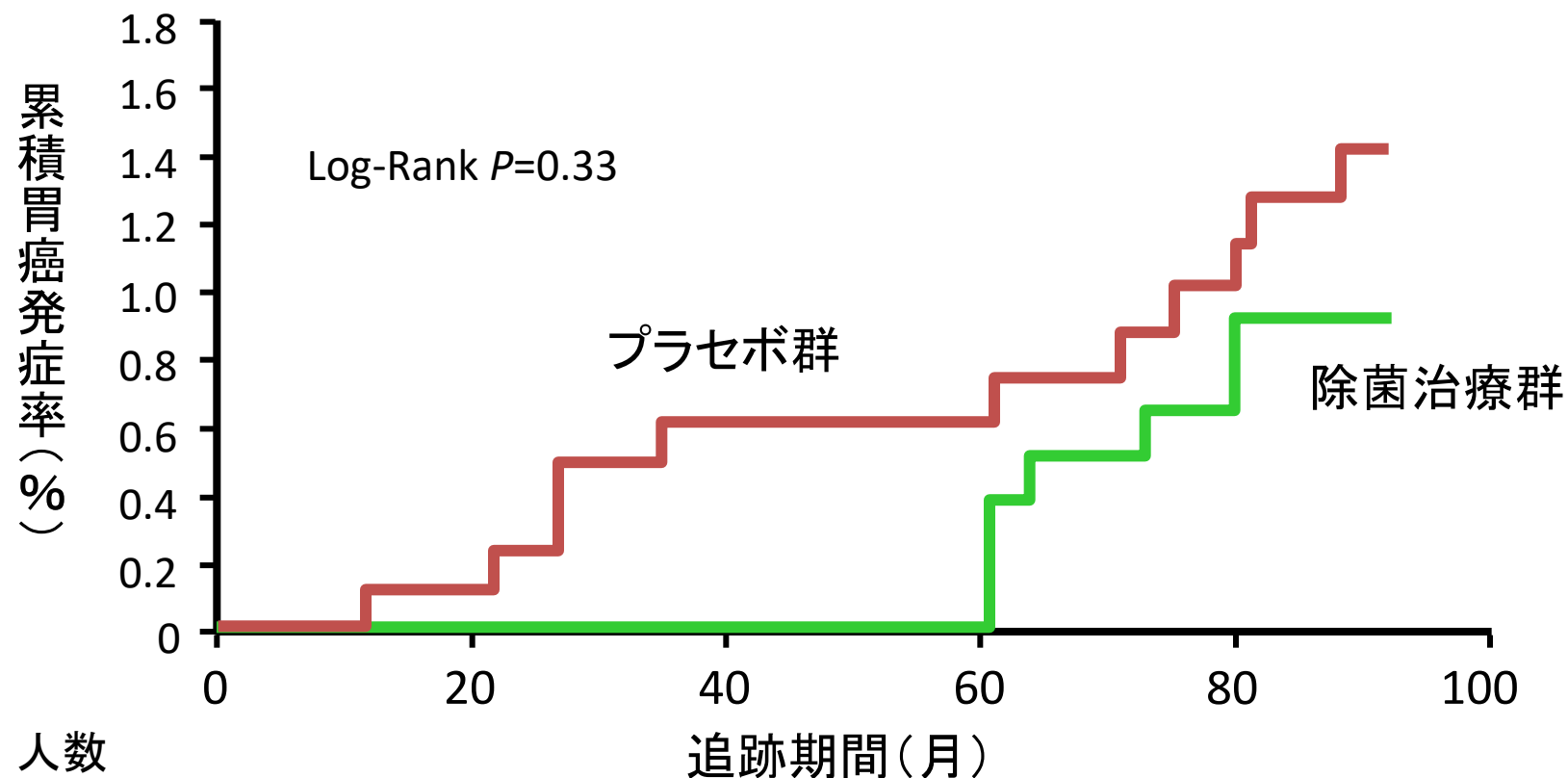


H.pylori 感染から胃癌に至るシーケンス



H. pylori 除菌群とプラセボ群の胃がん発症率

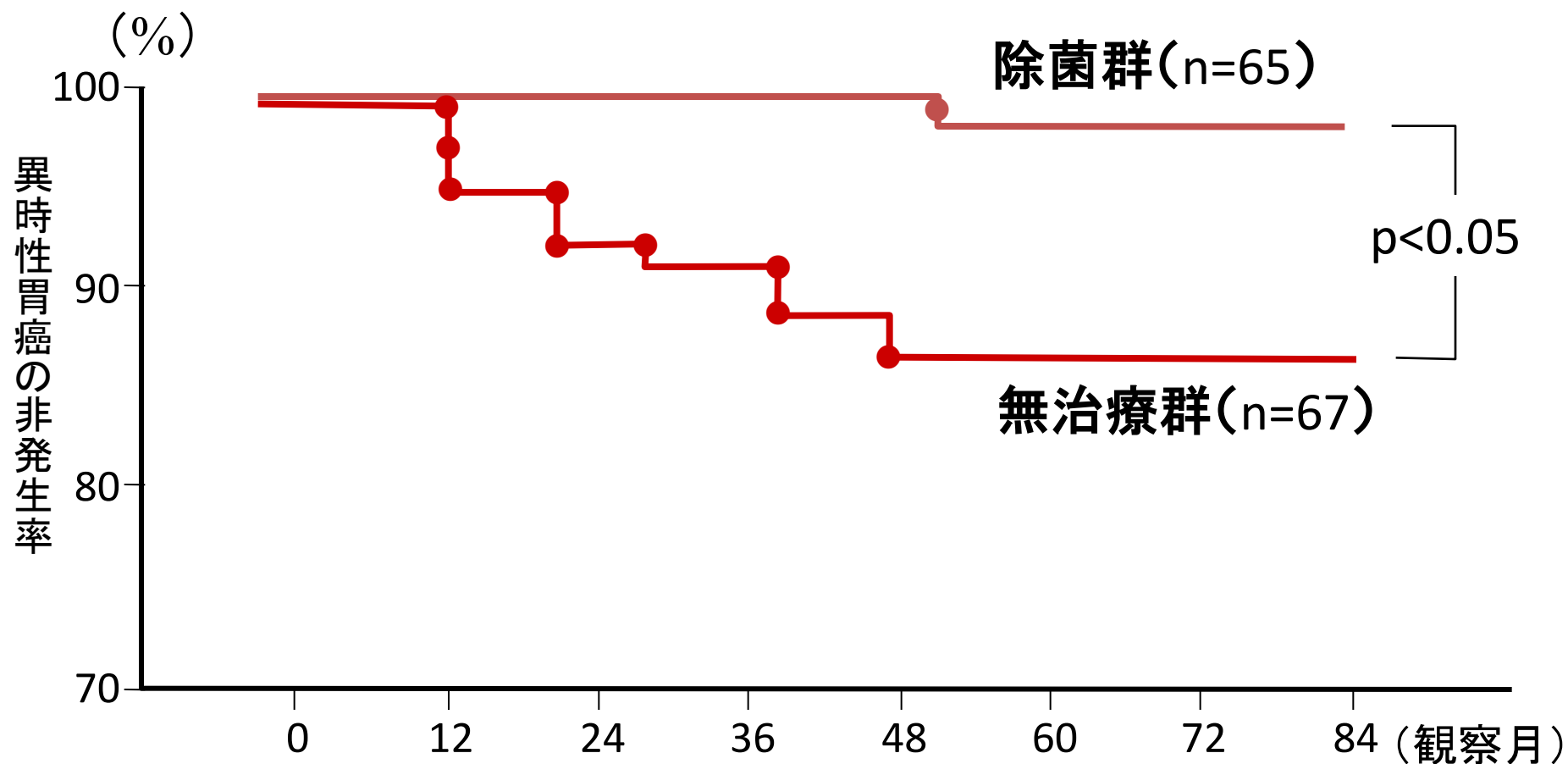
<全症例>



<i>H. pylori</i> 除菌群	817	806	798	790	747
プラセボ	813	790	781	774	741

慢性胃炎（萎縮性胃炎）の患者様でピロリ菌を除菌した方が非除菌者より胃がん発生率が低下する。

EMR後の異時性胃がん発生に対するピロリ菌除菌の影響
(68~118ヵ月、平均84ヵ月の観察期間)



胃・大腸癌における危険因子

WCRF/AICR 1997

	胃癌	大腸癌
確実 (convincing)	<i>H.pylori</i> 感染	
ほぼ確実 (probable)	食塩	赤身の肉 アルコール
可能性がある (possible)	デンプン類 焼き肉・魚	過体重・高身長 頻回の食事摂取 砂糖・卵・総脂肪 加工肉・高熱処理の肉
不十分 (insufficient)	燻製・乾燥などの 保存食 ニトロソアミン類	鉄

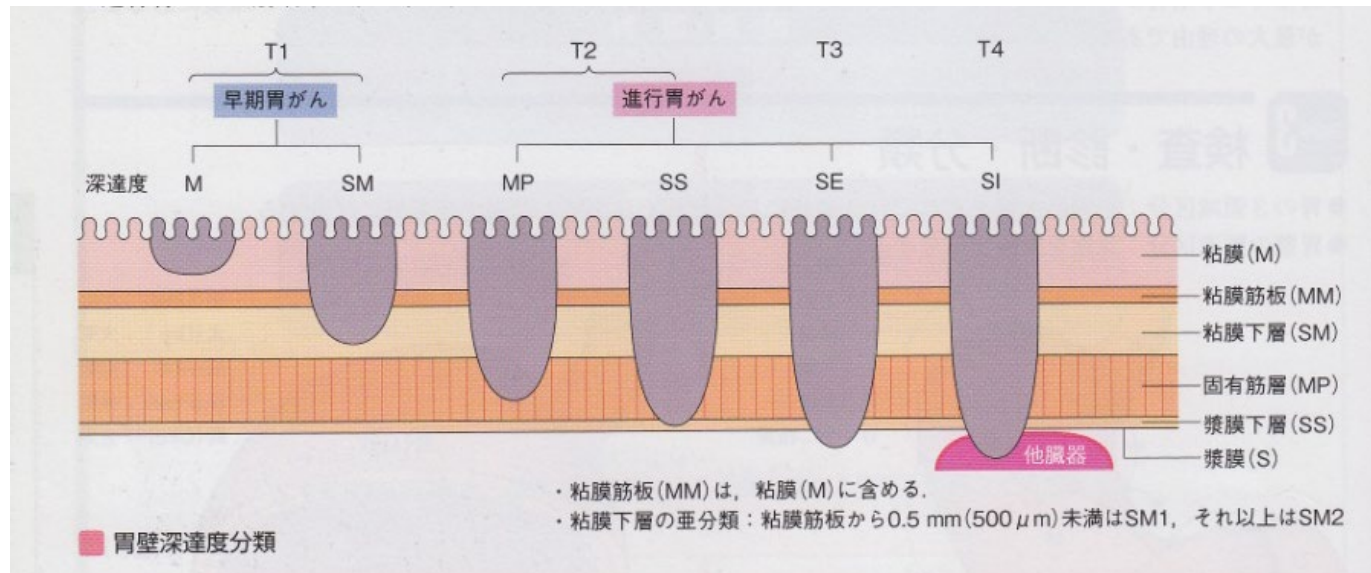
胃癌のリスク因子

ピロリ菌 + 食塩 > ピロリ菌 >>> 食塩

Tatematsu, M., Tsukamoto, T., and Mizoshita, T. History of Gastric Carcinoma Research in Japan: Basic Aspects. In: Kaminishi, M., Takubo, K., and Mafune, K. (eds). The Diversity of Gastric Carcinoma. Tokyo: Springer-Verlag; 2005. p. 3-28.

早期胃癌 進行胃癌

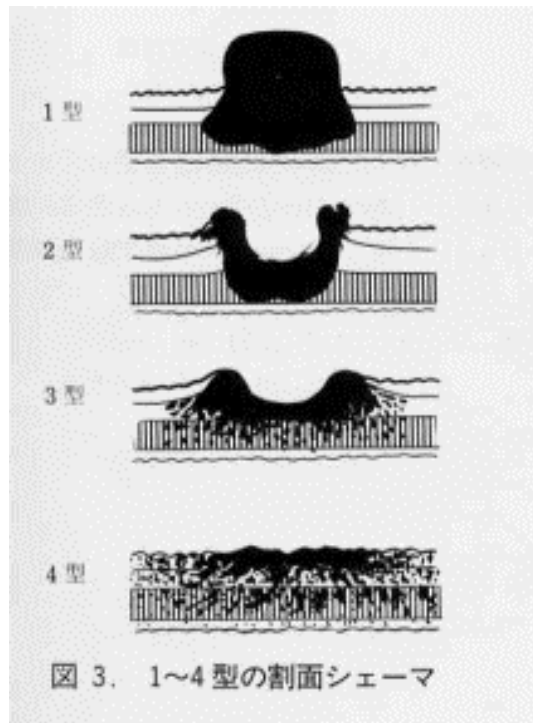
- 早期胃癌：深達度が**粘膜内、粘膜下層までにとどまるもの**。 **リンパ節転移は問わない**。
- 進行胃癌：深達度が固有筋層以深に達したものの。



胃癌 肉眼型分類

- 胃癌を粘膜面からみて形態を0型～5型に分類。0型（表在型）はⅠ型～Ⅲ型に亜分類される。

≡進行胃癌



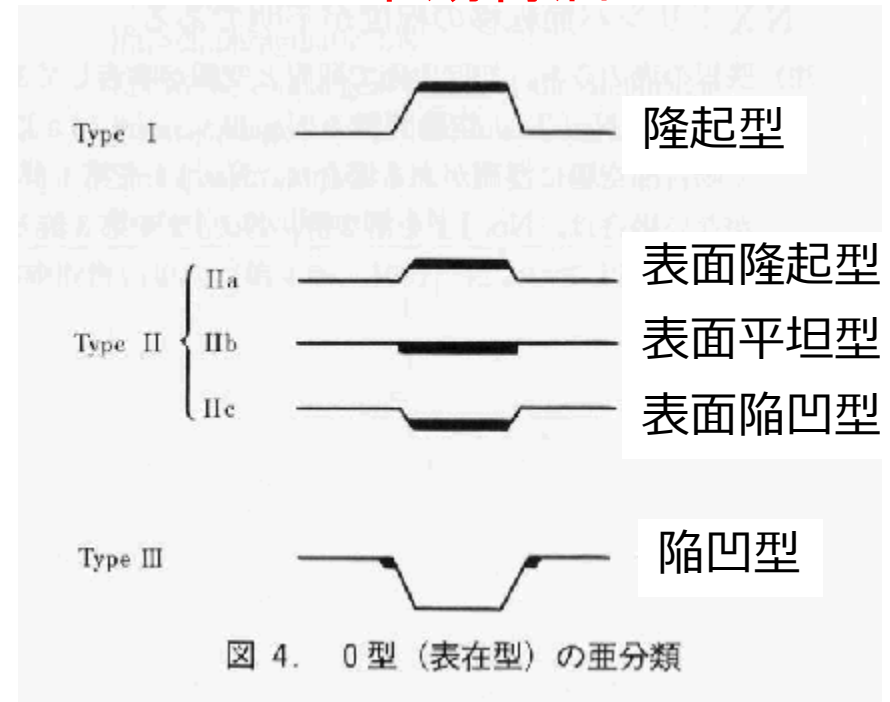
腫瘍型

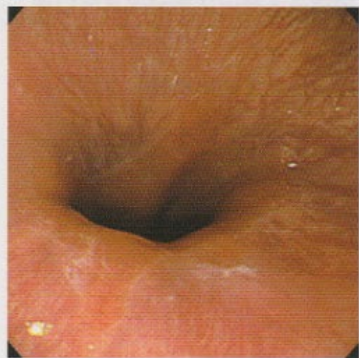
潰瘍限局型

潰瘍浸潤型

びまん浸潤型

≡早期胃癌





食道・胃境界部



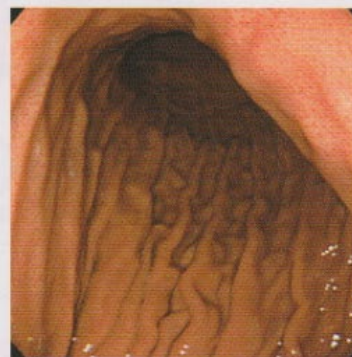
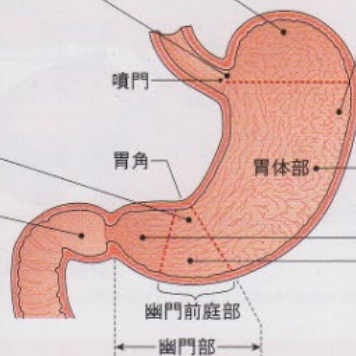
胃穹窿部



胃体上部(大彎)



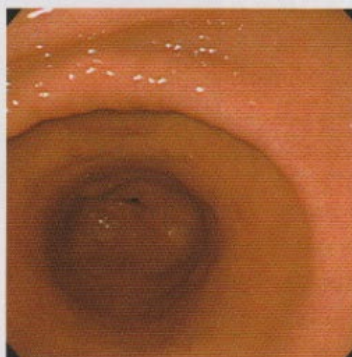
胃角部



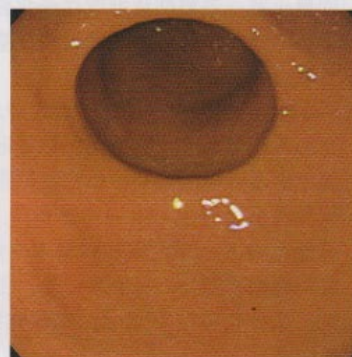
胃体部(大彎)



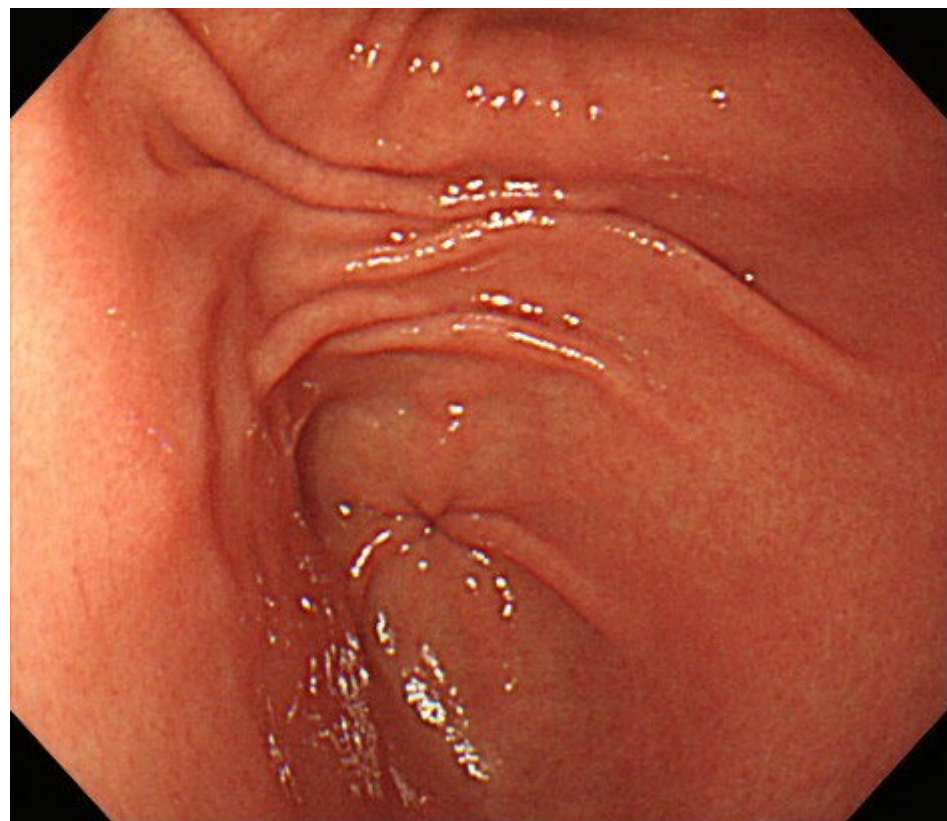
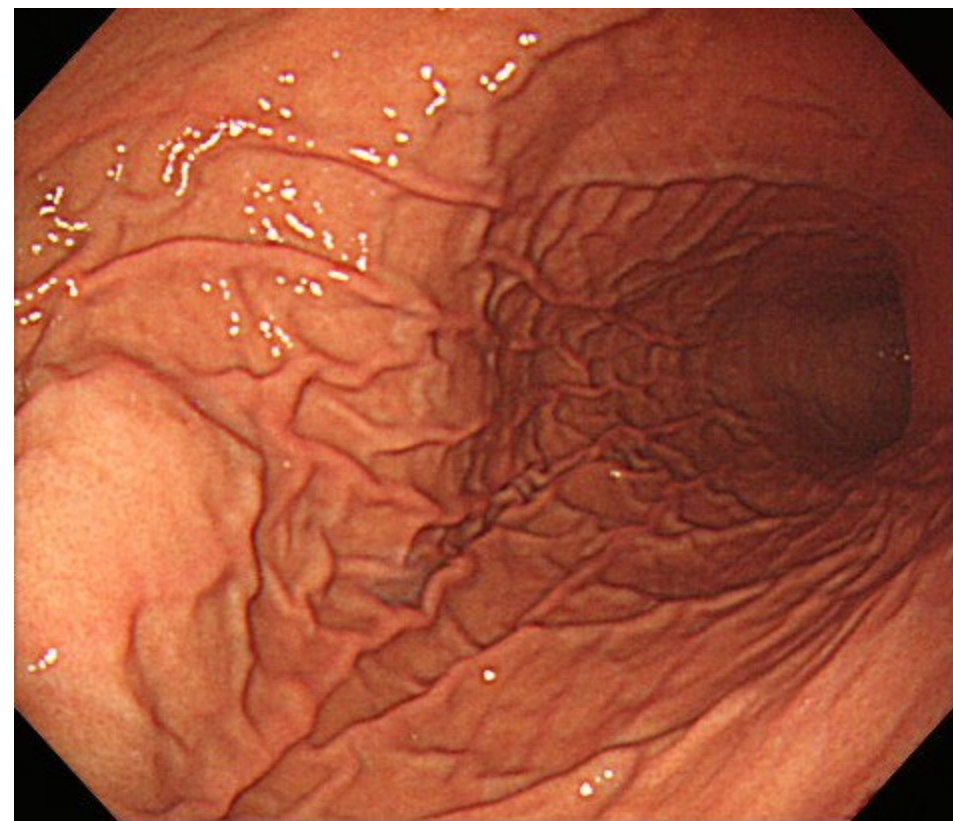
十二指腸球部



幽門部

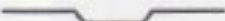
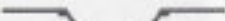


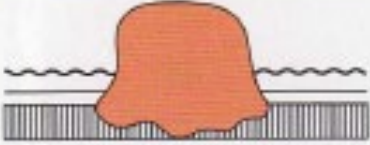
幽門前庭部



胃 正常

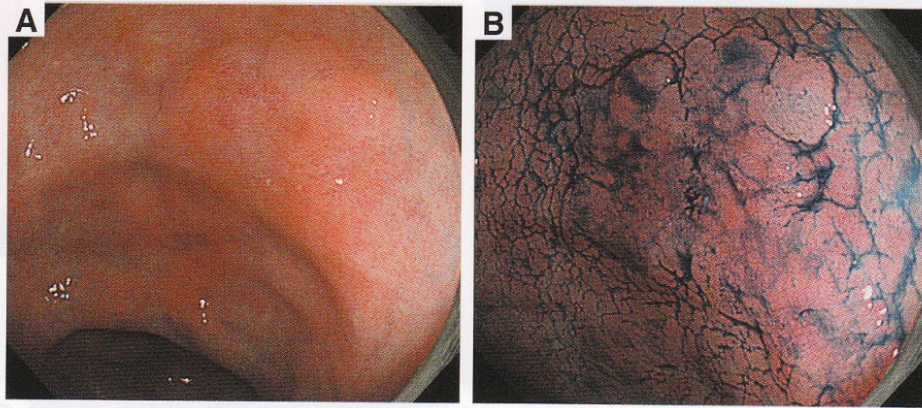
O 型：表面型

O-I 型	O-II a 型	O-II b 型	O-II c 型	O-III 型
隆起型	表面隆起型	表面平坦型	表面陷凹型	陷凹型
				
				

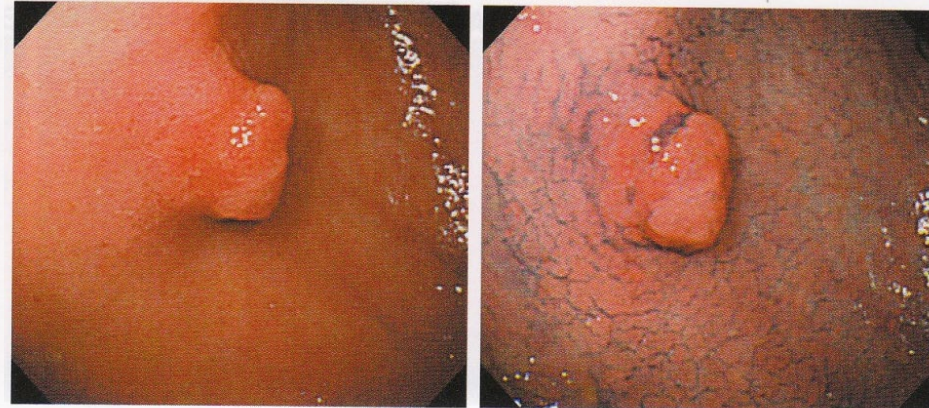
1 型	2 型	3 型	4 型
腫瘍型	潰瘍限局型	潰瘍浸潤型	びまん浸潤型
			
			

これは何型？

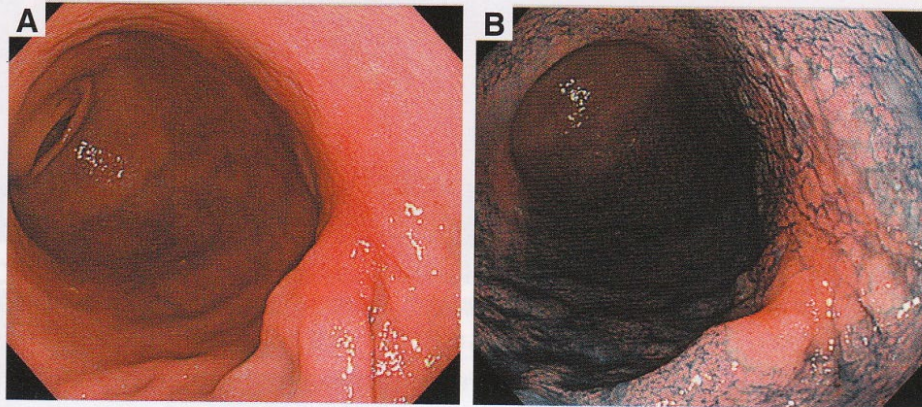
0-Ⅱa型（表面隆起型）



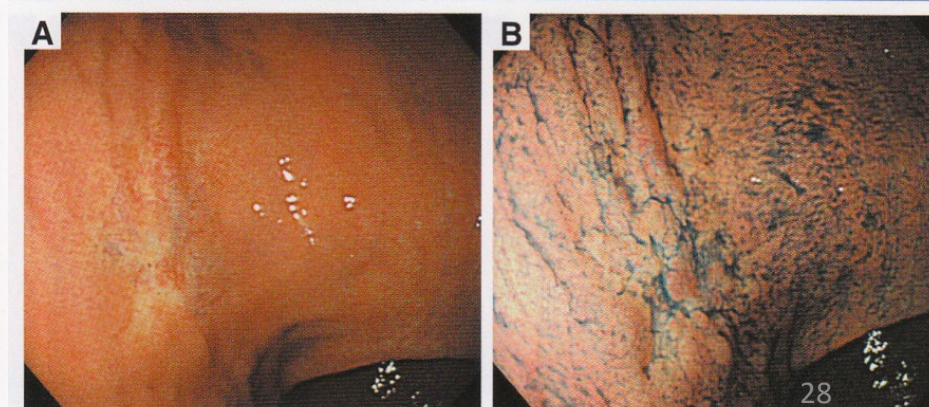
0-Ⅰ型（隆起型）



0-Ⅱc型（表面陥凹型）

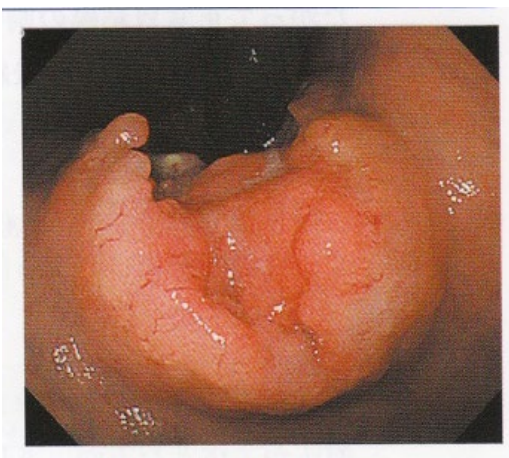


0-Ⅱc型（表面陥凹型）

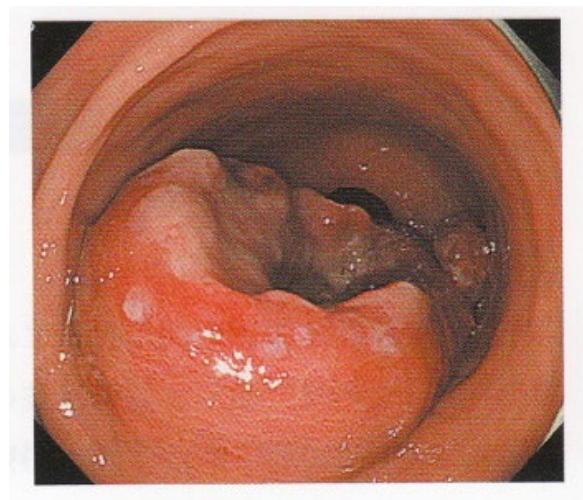


これは何型？

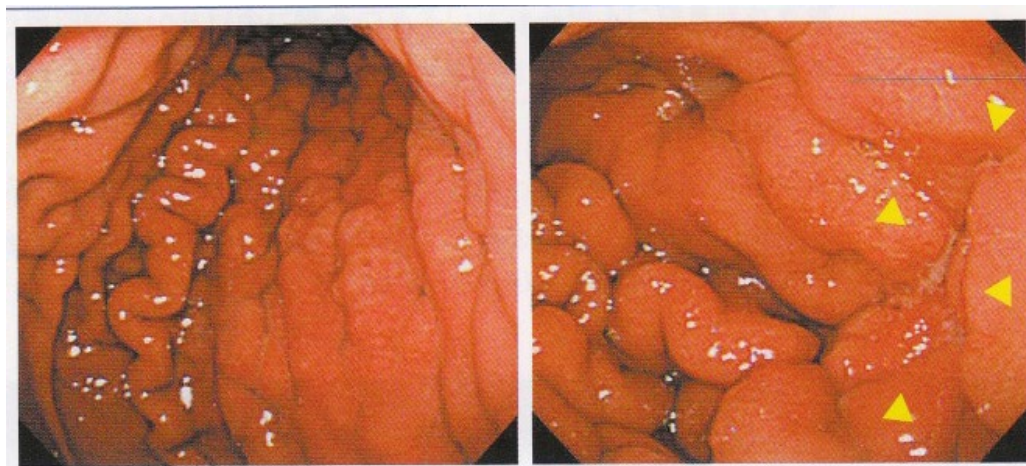
3型



2型

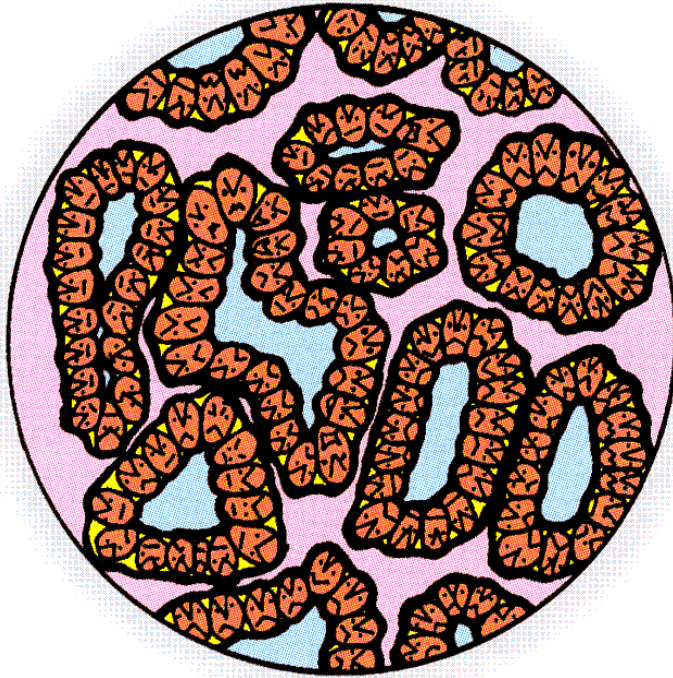


4型



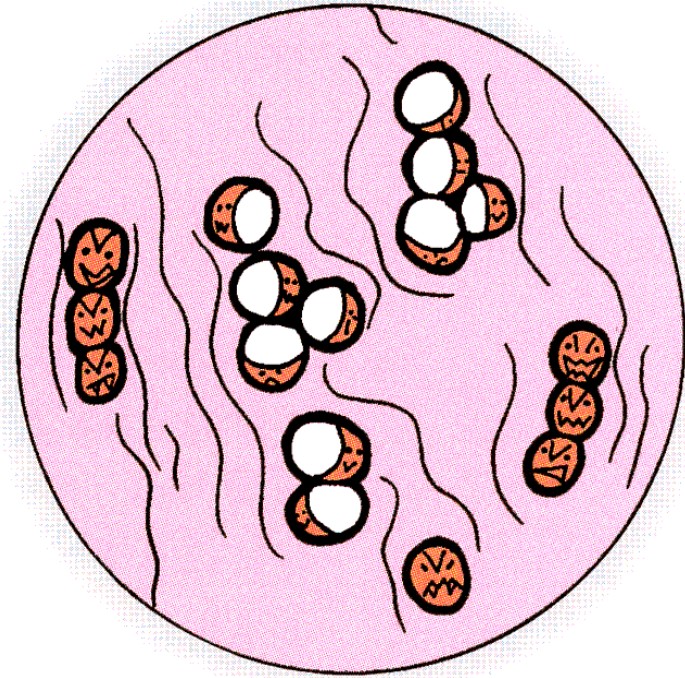
分化型胃癌と未分化型胃癌

分化型胃癌



癌細胞の形や並び方が
胃や腸の粘膜構造を残した癌

未分化型胃癌

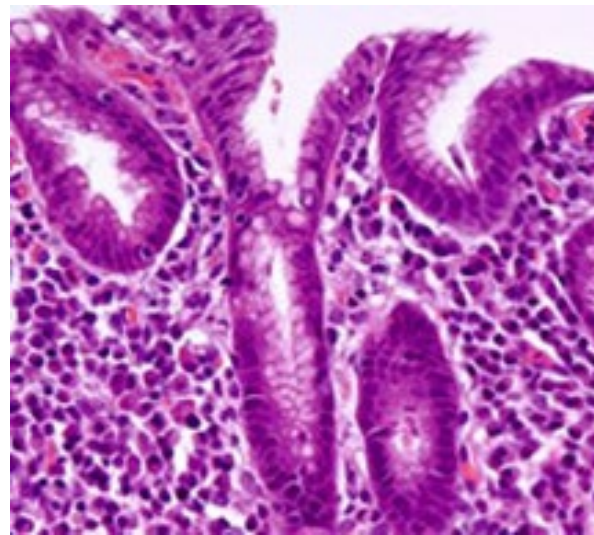


癌細胞の形や並び方に
胃や腸の粘膜構造の少ない癌

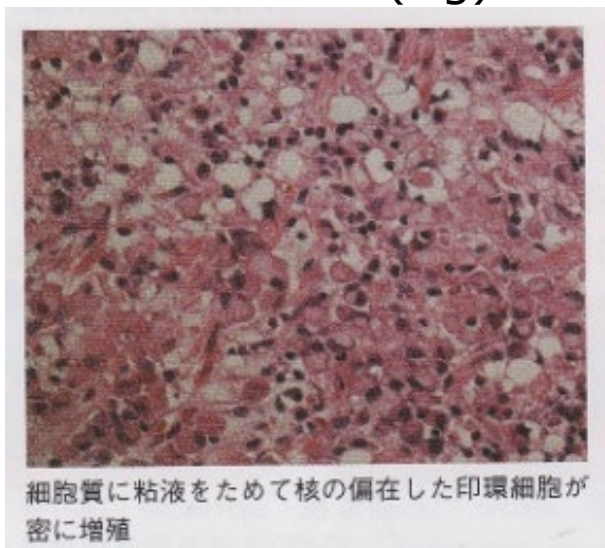
組織型分類

分化型癌	一般型	乳頭腺がん(pap)	
		管状腺がん(tub)	高分化型(tub1)
			中分化型(tub2)
		低分化腺がん(por)	充実型(por1)
			非充実型(por2)
未分化型癌	特殊型	印環細胞がん(sig)	
		粘液がん(muc)	
		腺扁平上皮がん	
		扁平上皮がん	
		カルチノイド腫瘍	
		その他のがん	

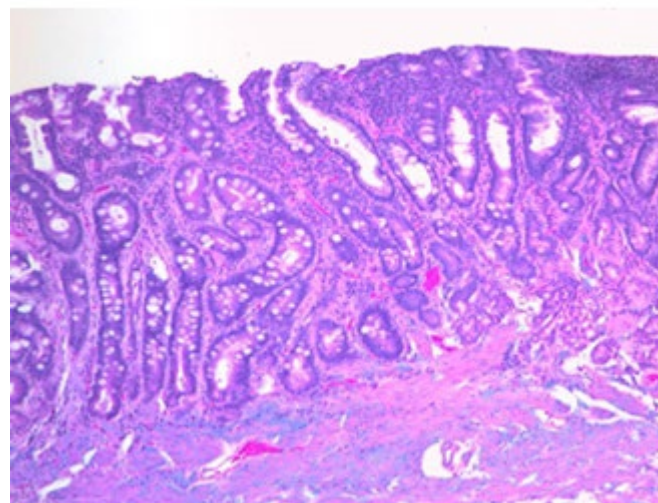
正常胃粘膜



印環細胞癌(sig)

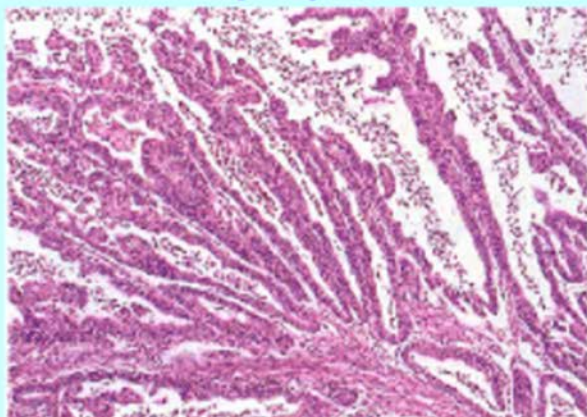


正常胃粘膜

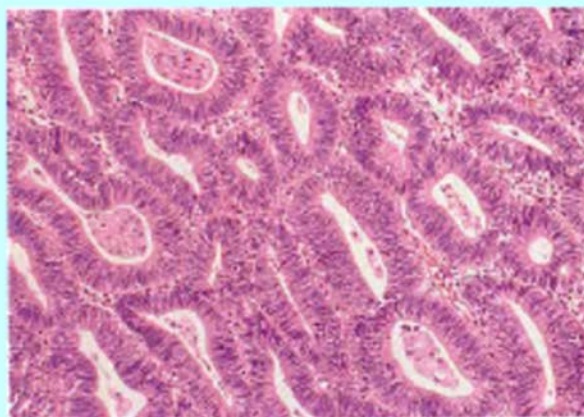


胃癌組織写真

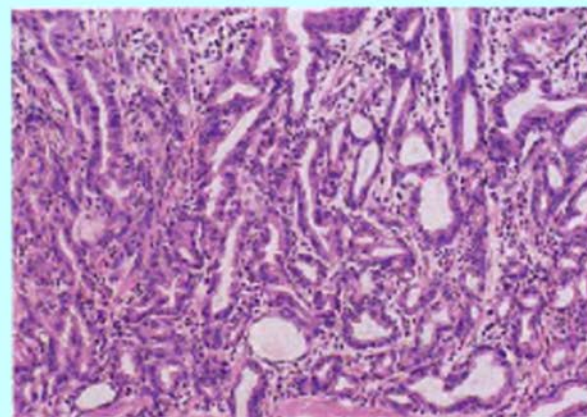
pap



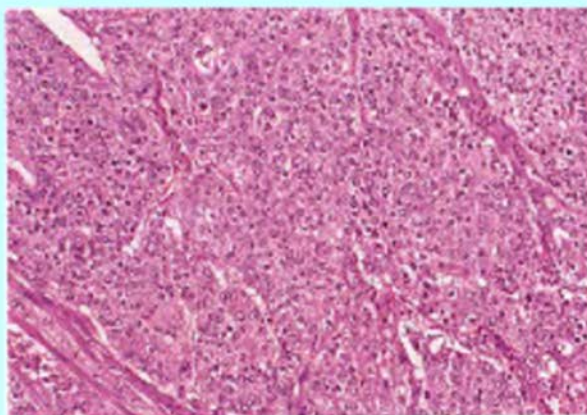
tub1



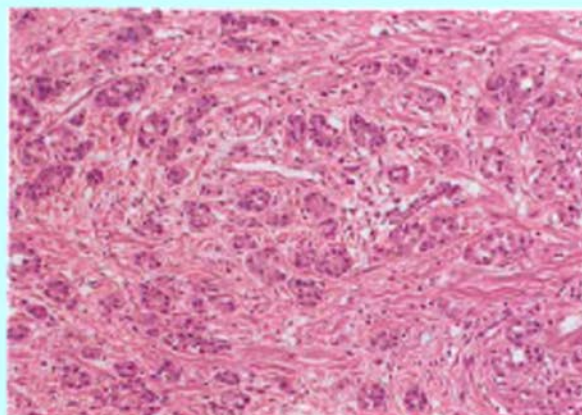
tub2



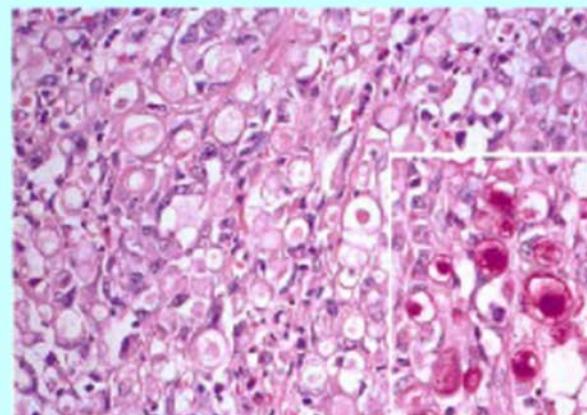
por1



por2



sig



上段:分化型 下段:未分化型

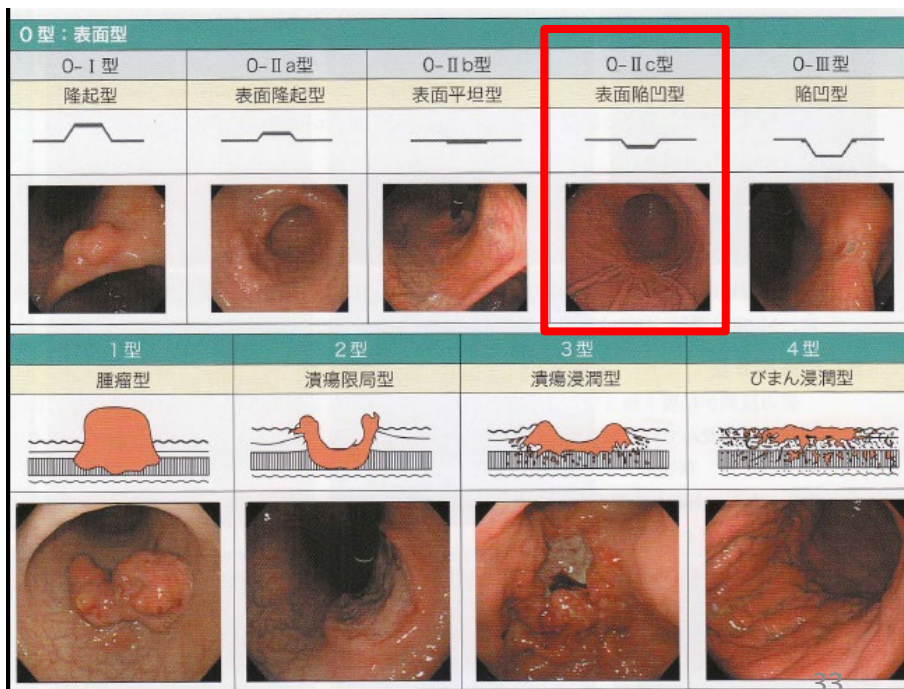
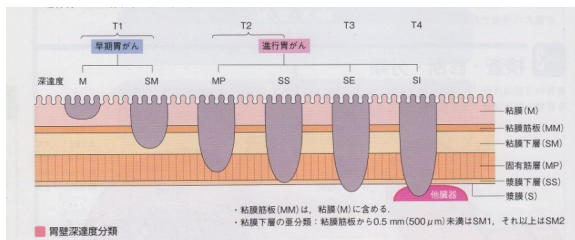
医師国家試験過去問 1

早期胃癌に関連して正しいのはどれか。2つ選べ。

- a 癌浸潤が粘膜下層までにとどまる。
- b 浸潤型は直径2cm以上にならない。
- c II c型が最も多い。
- d II a型の表面色調は蒼白のことが多い。
- e リンパ節転移はない。

早期胃癌 進行胃癌

- 早期胃癌：深達度が粘膜内、**粘膜下層まで**にとどまるもの。**リンパ節転移は問わない。**
- 進行胃癌：深達度が固有筋層以深に達したもの。



医師国家試験過去問 6

早期胃癌の肉眼型で発生頻度の最も高いのはどれか。1つ選べ。

a I 型

b II a 型

c II b 型

d II c 型

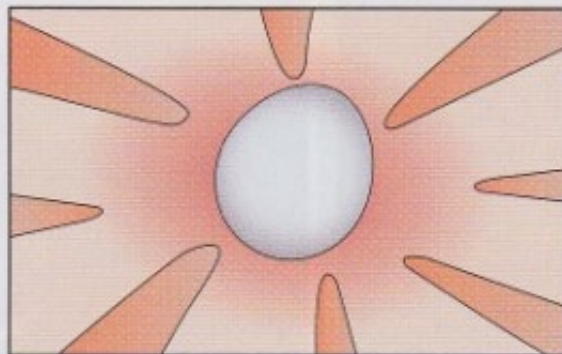
e III 型

胃潰瘍と胃癌の鑑別 1

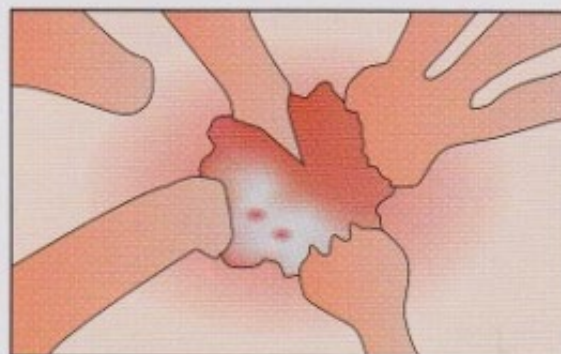
胃潰瘍と胃癌の内視鏡像の鑑別点

- 診断のポイントは、再生発赤のない潰瘍辺縁から生検することと、潰瘍の好発部位と異なる場合は、がんを疑うことである。

胃潰瘍

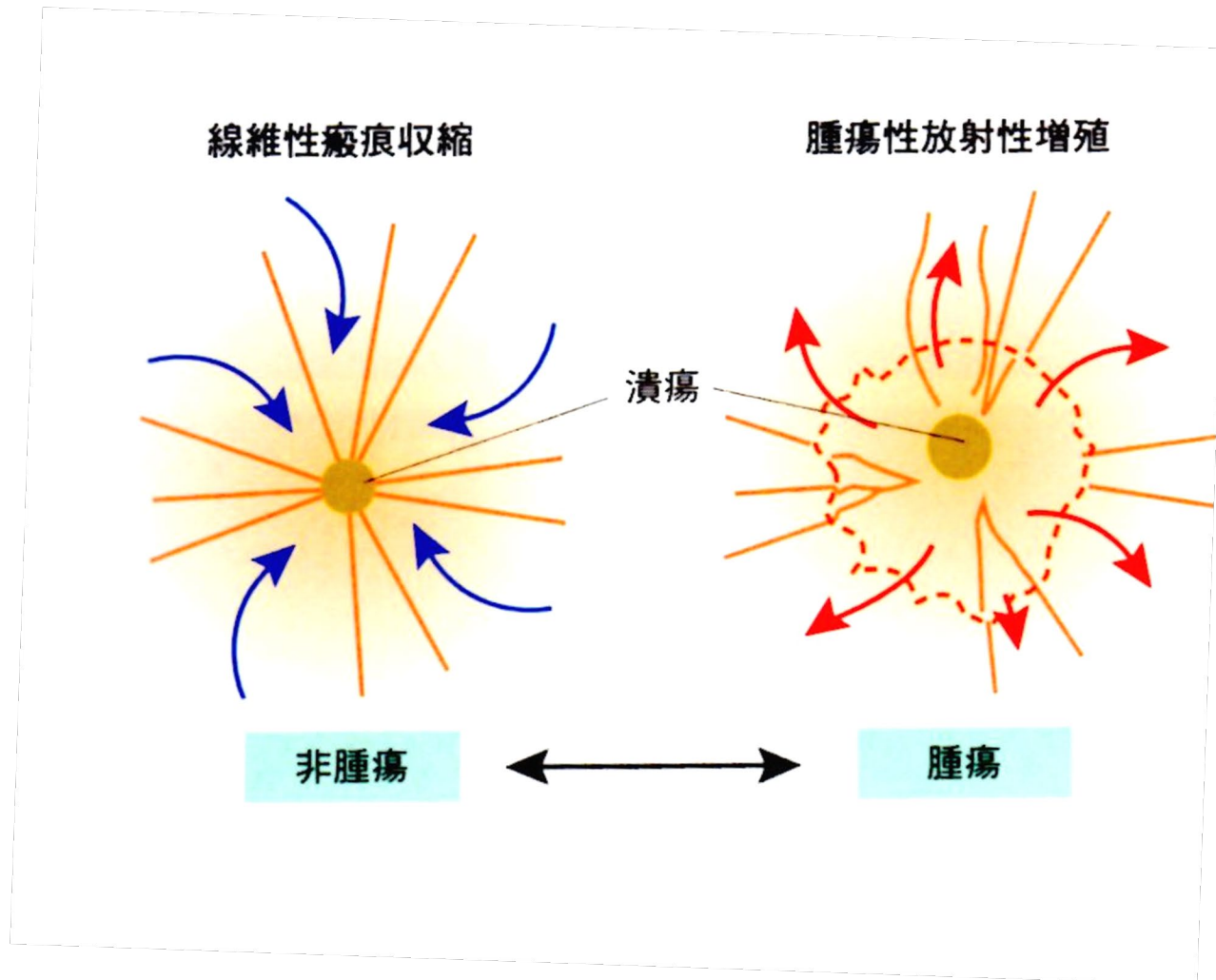


胃癌

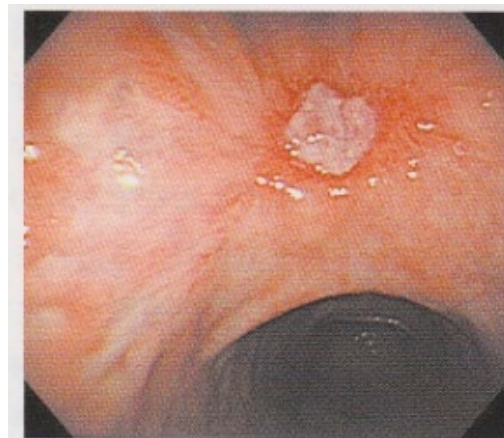
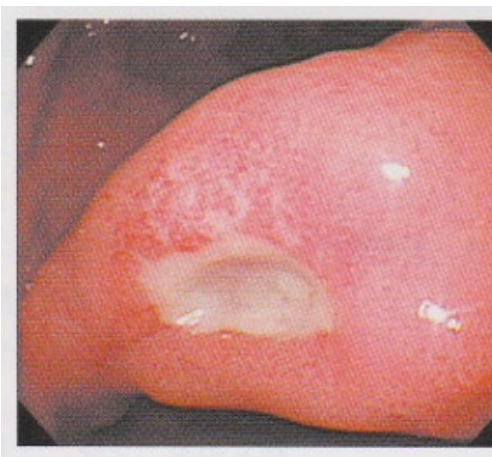


潰瘍の辺縁	● 円形または卵円形	● 不整形，形の変化(悪性サイクル)
潰瘍面	● 比較的平滑	● 島状結節，無構造，不均一
白苔	● 厚く，均一	● 不均一，出血
潰瘍周囲の隆起	● なだらか	● 急峻
皺襞	● スムーズな先細り	● 虫食い，中断，棍棒状腫大 ペン先のような不整な先細り，癒合
再生発赤	● 柵状で幅や色調が均一	● 分布や程度が不整

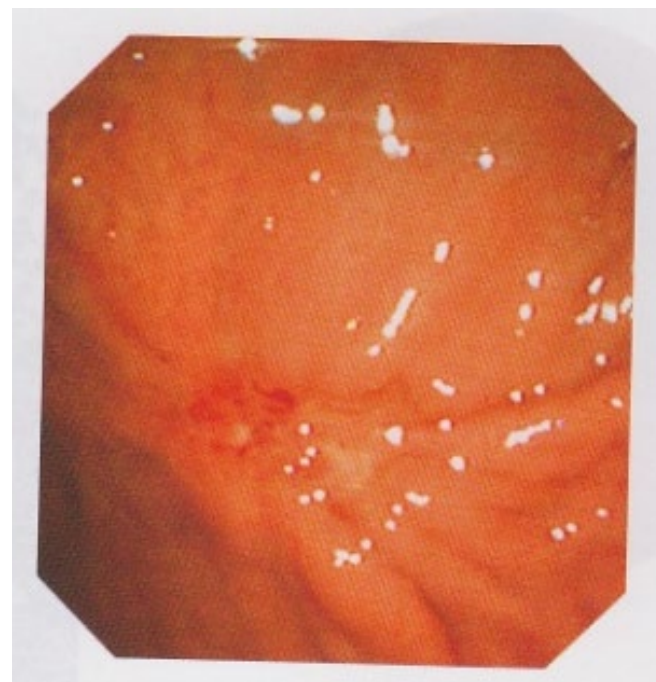
胃潰瘍と胃癌の鑑別 2



胃潰瘍



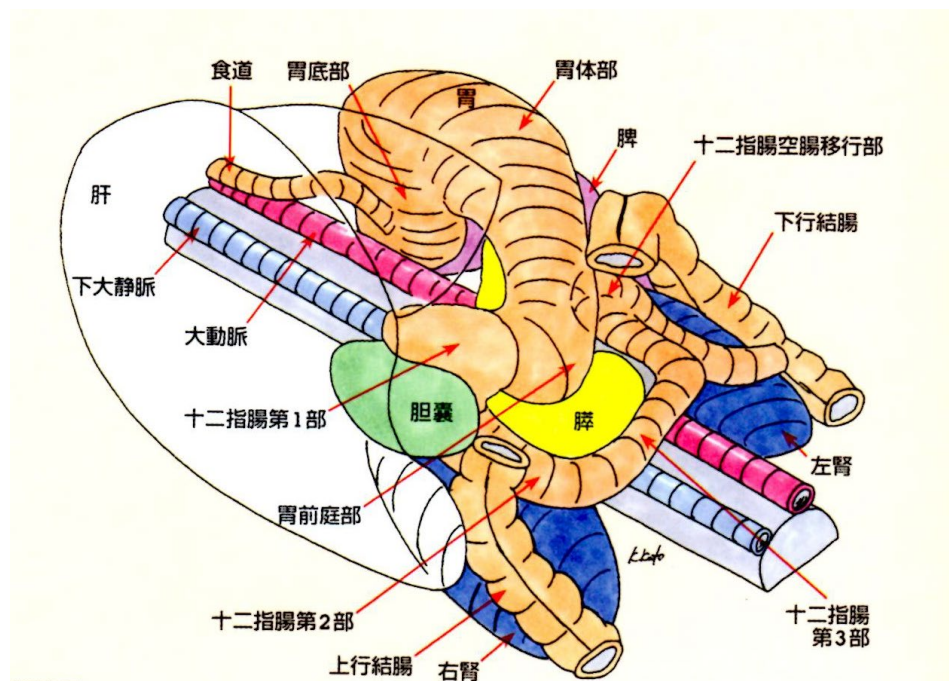
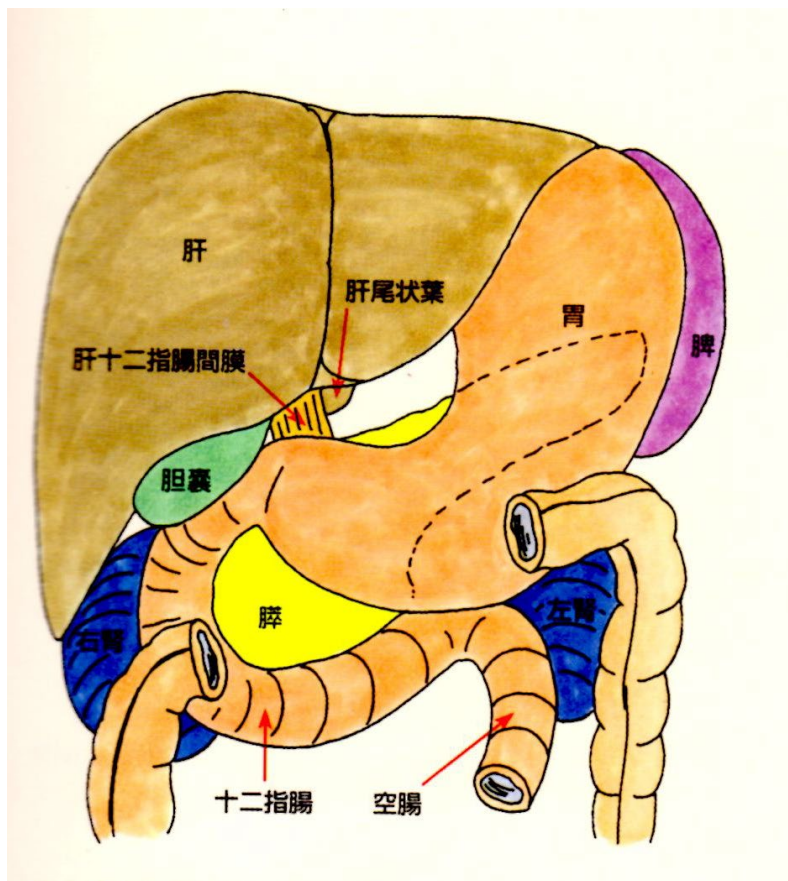
胃癌 (0-Ⅲ 型)



胃癌 進展

- 直接浸潤：隣接臓器を浸潤し、**膵臓**や**横行結腸**に進展する。噴門部胃癌が下部食道に進展することもある。
- リンパ行性転移：左鎖骨上窩リンパ節（**Virchow転移**）
- 血行性転移：**肝臓**、肺、骨、脳
- 腹膜播種：**Krukenberg腫瘍**（腺癌の卵巣転移）、**Schnitzler転移**（Douglas窩に転移）

胃の解剖



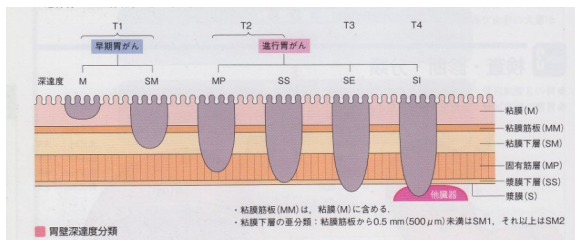
医師国家試験過去問 3

胃癌について正しいのはどれか。2つ選べ。

- a 年齢調節死亡率は増加している。
- b スキルス癌は高齢者に多い。
- c 早期癌とは深達度が粘膜下層まででリンパ節転移のないものをいう。
- d 左鎖骨上窩リンパ節に転移する。
- e 再発形式で最も多いのは腹膜播種性転移である。

早期胃癌 進行胃癌

- 早期胃癌：深達度が**粘膜内、粘膜下層まで**にとどまるもの。**リンパ節転移は問わない。**
- 進行胃癌：深達度が固有筋層以深に達したもの。



胃癌 進展

- 直接浸潤：隣接臓器を浸潤し、**脾臓**や**横行結腸**に進展する。噴門部胃癌が下部食道に進展することもある。
- リンパ行性転移：左鎖骨上窩リンパ節 (**Virchow 転移**)
- 血行性転移：肝臓、肺、骨、脳
- 腹膜播種：**Krukenberg 腫瘍** (腺癌の卵巣転移)、**Schnitzler 転移** (Douglas窩に転移)

胃癌 症状

- 早期胃癌では特に症状はなく、健診などを契機に発見されることが多い
- 進行胃癌では心窩部痛、食欲不振、黒色便、貧血症状、体重減少など

胃癌 検査

- 血液検査：貧血、腫瘍マーカー（CEA、CA19-9）
- 消化管造影
- 内視鏡
- CT：遠隔転移、周囲臓器への浸潤

消化管造影（胃透視）



胃透視



背臥位二重造影正面位



背臥位二重造影第一斜位

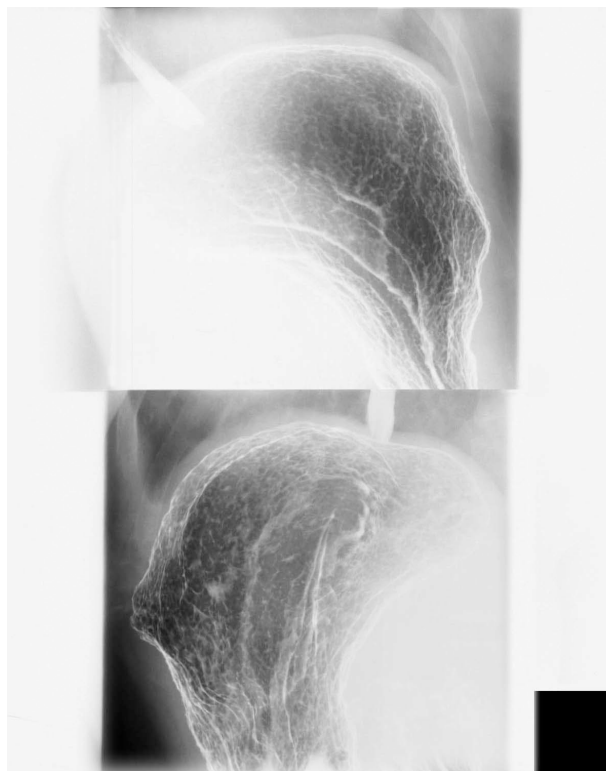


背臥位頭低位第二斜位

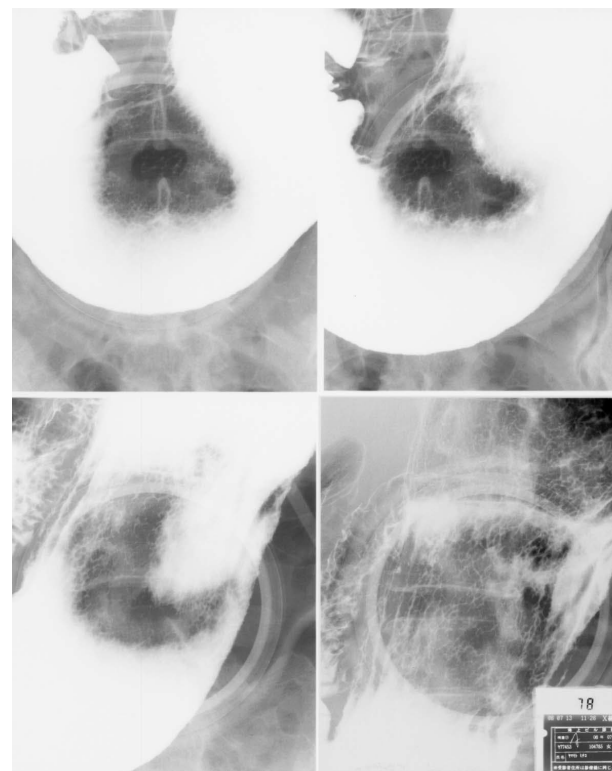
胃透視



腹臥位二重造影第二斜位

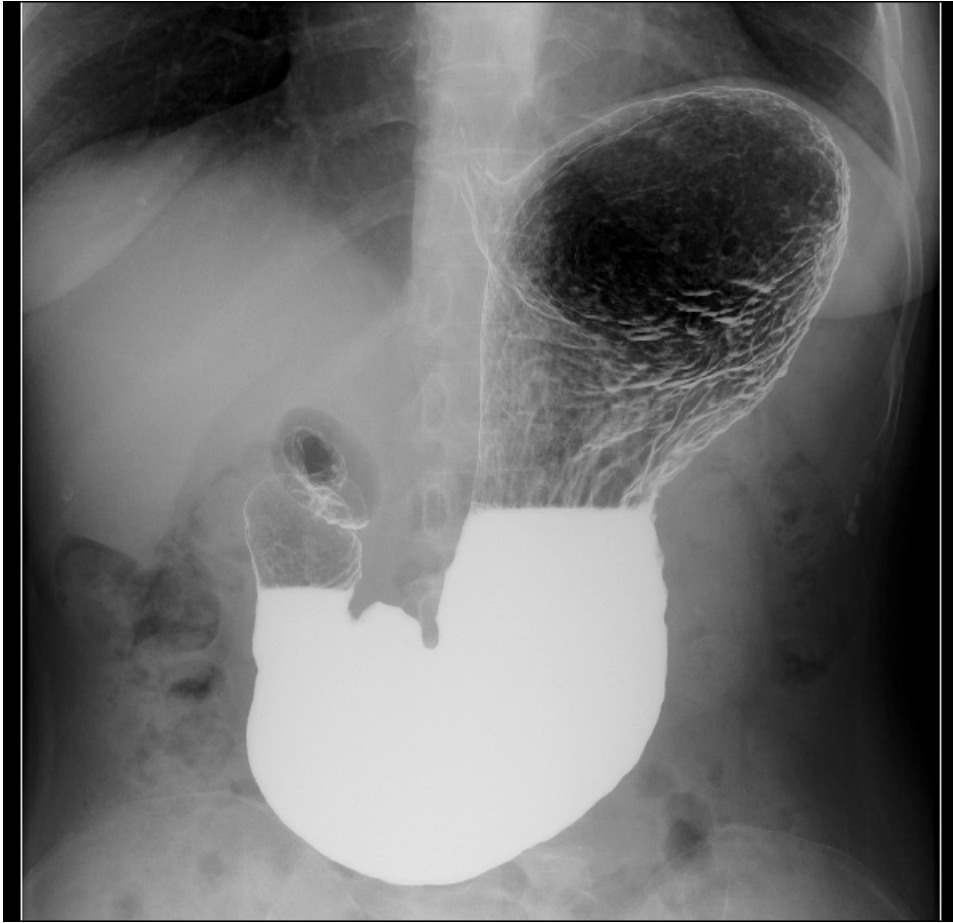


半立位第一斜位二重造影
右側臥位胃上部二重造影

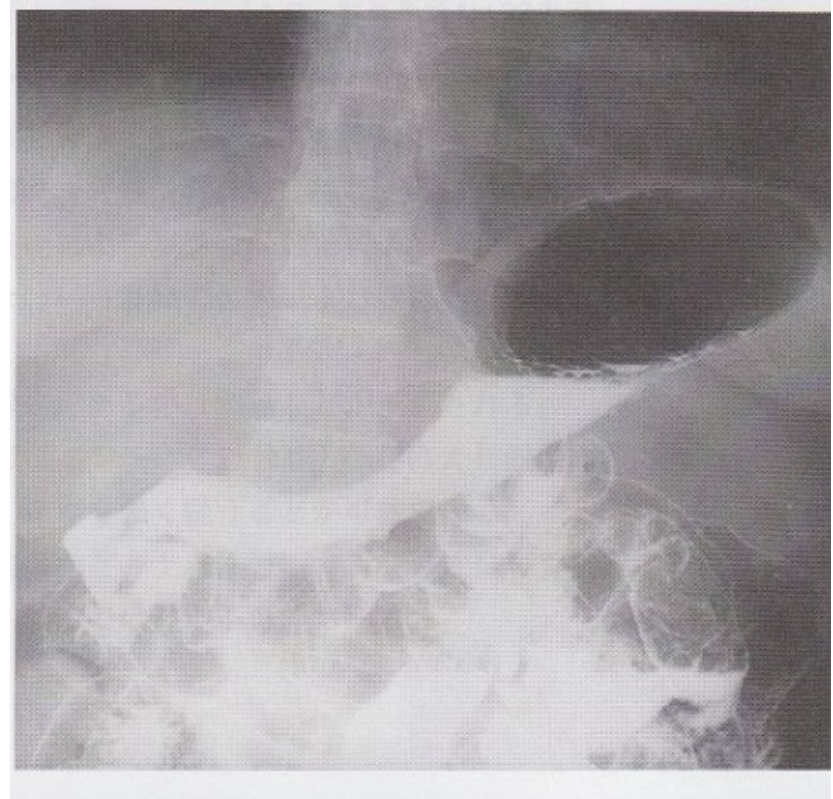


半臥位压迫像

胃透視

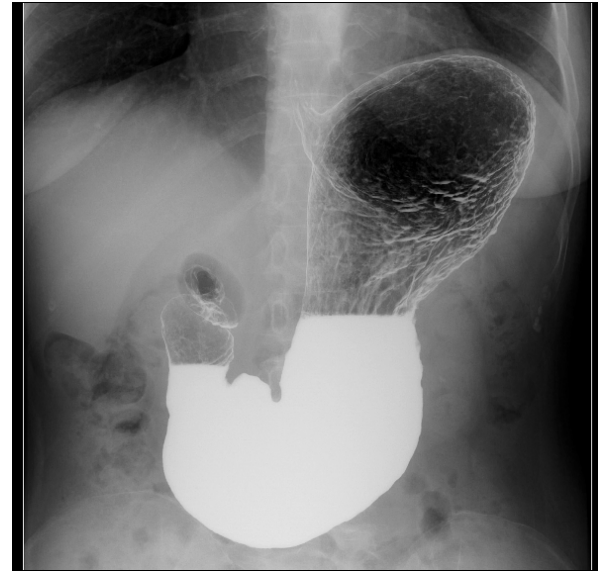
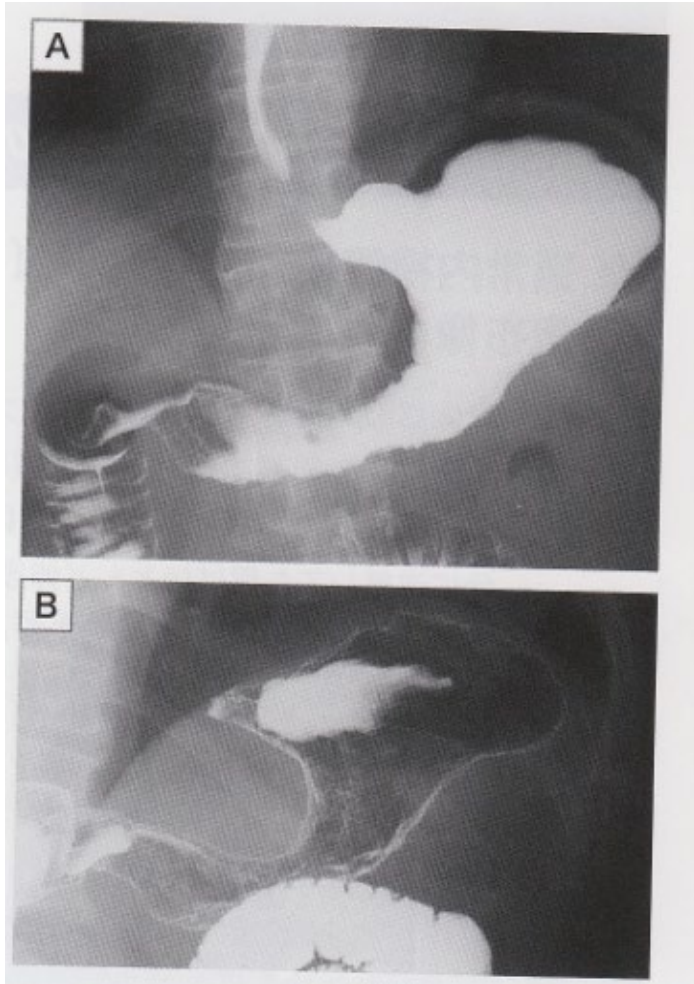


立位充滿正面像

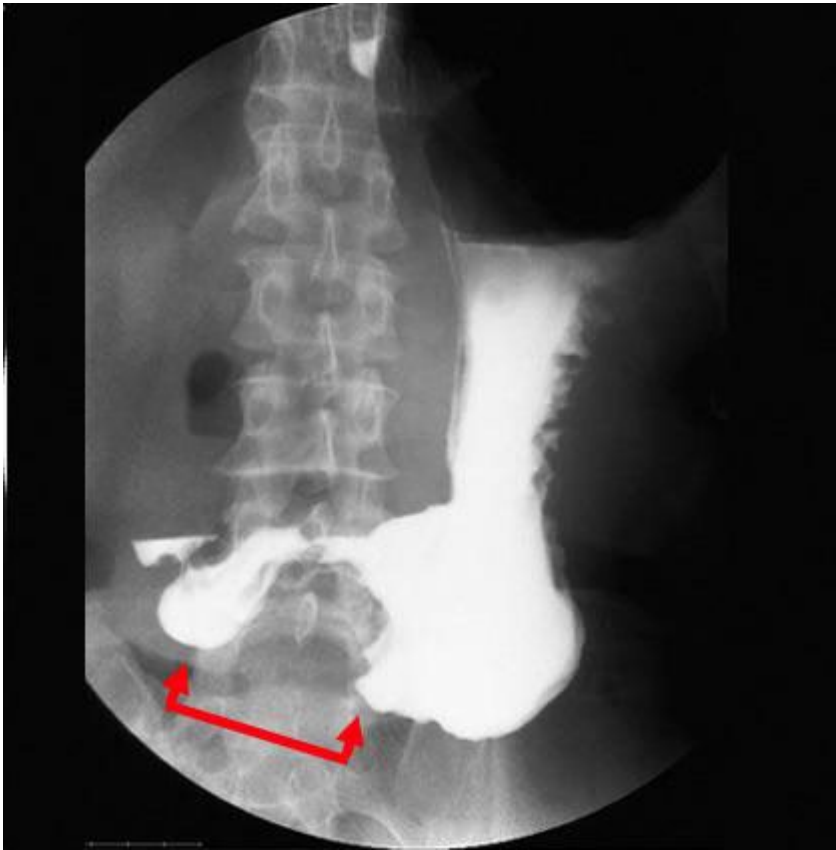


医師国家試験過去問 2

どこが異常でしょうか？



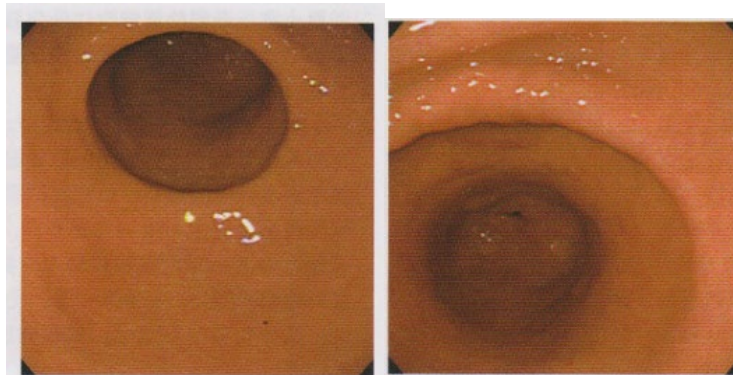
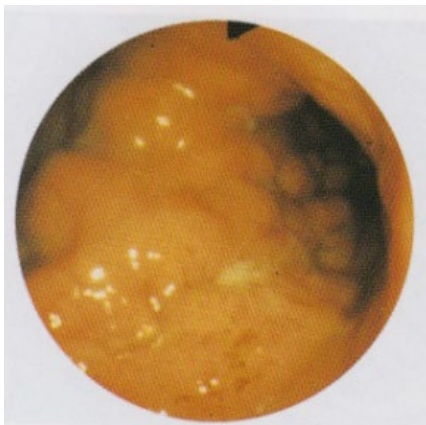
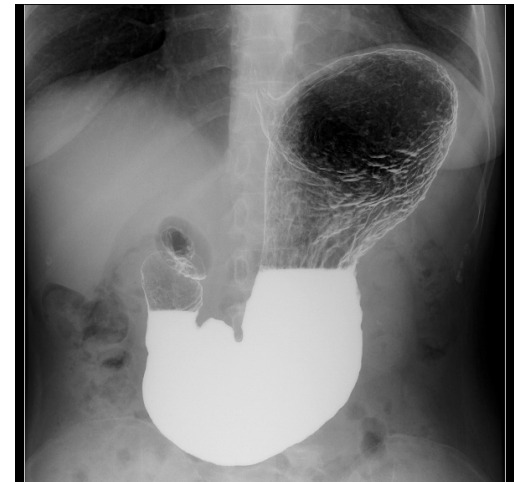
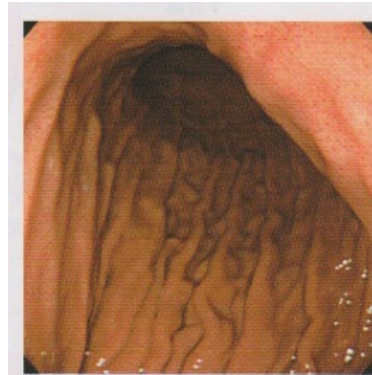
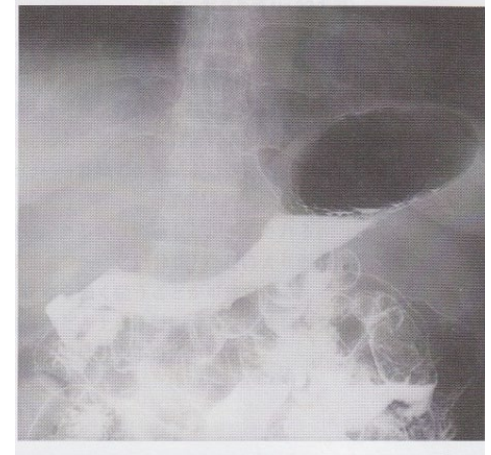
どこが異常でしょうか？



医師国家試験過去問 4

48歳の女性。2か月前から腹痛と腹部膨満感とが出現し、背部痛を伴ってきたので来院した。腹部超音波検査で両側の卵巣に腫瘍像を認めた。赤血球306万、Hb11.0g/dl白血球4700、血小板3.2万。血清生化学所見：AST33IU/l、ALT19IU/l、LDH521IU/l（正常370以下）、プロトロンビン時間18秒（正常10～14）、血漿フィブリノゲン100mg/dl（正常170～410）。赤沈3mm/1時間。胃内視鏡写真と胃エックス線造影検査とを別に示す。この患者について考えられるのはどれか。

- (1)カルチノイド症候群
- (2)paraneoplastic syndrome
- (3)播種性血管内凝固症候群(DIC)
- (4)Krukenberg腫瘍
- (5)Meigs症候群



胃癌 治療

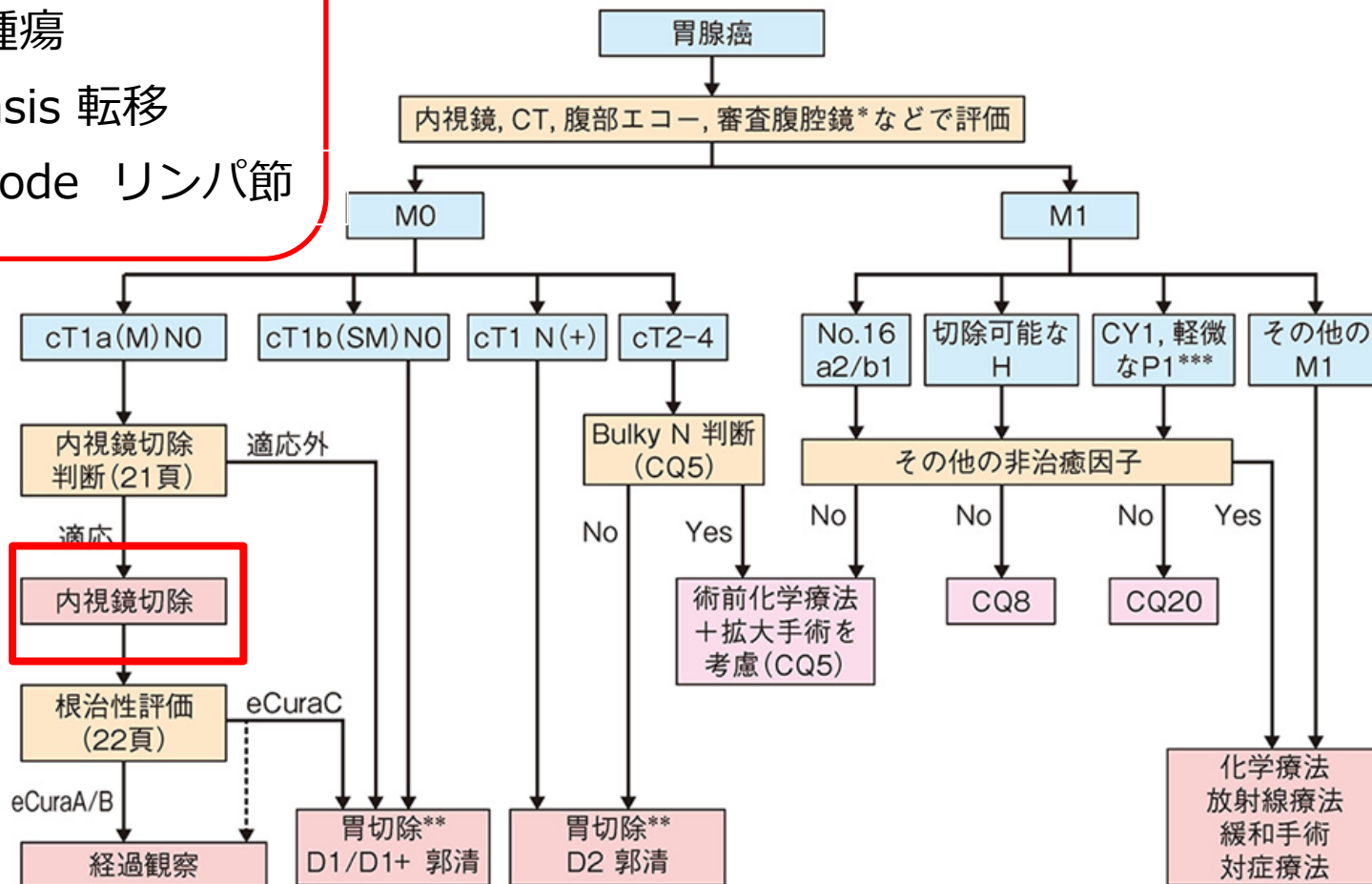
- 内視鏡治療 EMR、ESDなど
- 外科的治療 幽門側胃切除術、胃全摘術など
- 化学療法 フッ化ピリミジン系（5-FU）とオキサリプラチン（L-OHP）の併用など

TNM分類

T : tumor 腫瘍

M : metastasis 転移

N : lymph node リンパ節



絶対適応病変

肉眼的粘膜内癌 (cT1a) と診断される分化型癌。
3cm以下のcT1a癌、UL1と診断される分化型癌。
2cm以下のcT1a癌、UL0、未分化型癌

*審査腹腔鏡の適応についてはCQ10を参照

**腹腔鏡手術の適応については17頁参照

***胃周囲や大網の表面などに少数個存在する結節で、
胃切除術の際に容易に切除可能なもの

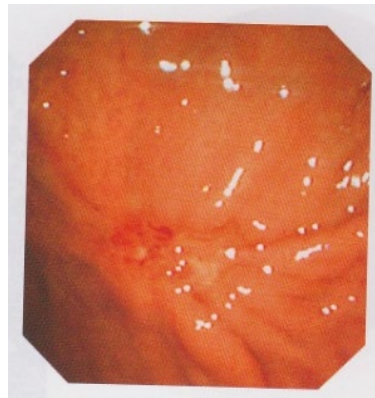
日常診療で推奨される治療選択のアルゴリズム

医師国家試験過去問 2

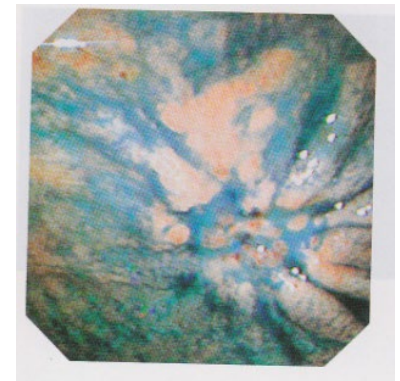
57歳の男性。胃のもたれ感を訴えて来院した。胃内視鏡検査を行った。インジゴカルミン色素散布前後の胃内視鏡写真(A,B)と生検組織H-E染色標本(C)とを別に示す。適切な治療法はどれか。

- a 消化酵素薬投与
- b 胃粘膜保護薬投与
- c ヒスタミンH2受容体拮抗薬投与
- d ヘリコバクター・ピロリ除菌療法
- e 胃切除術**

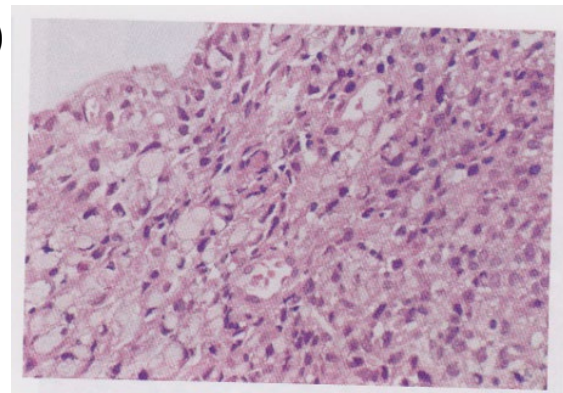
(A)



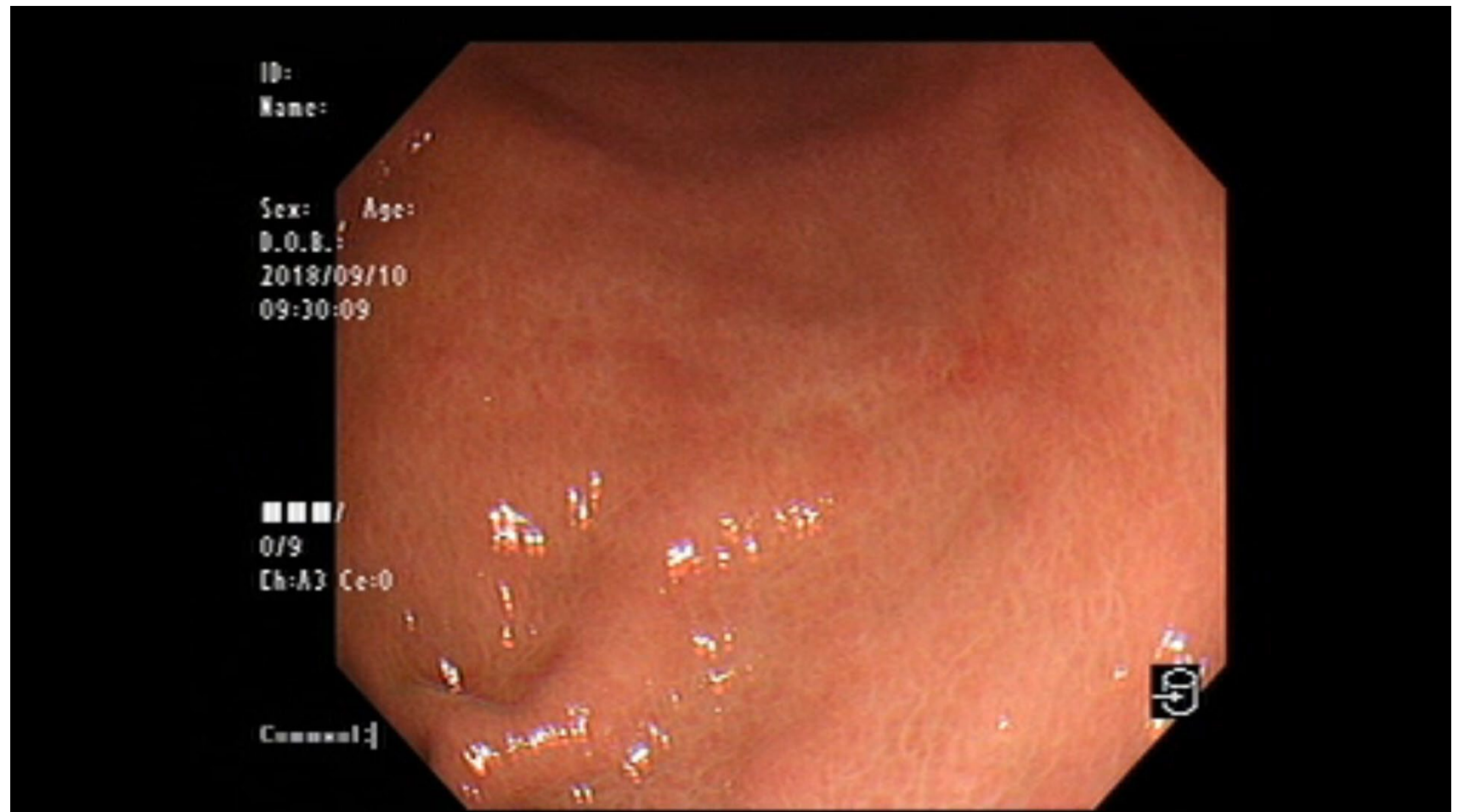
(B)



(C)



胃ESD

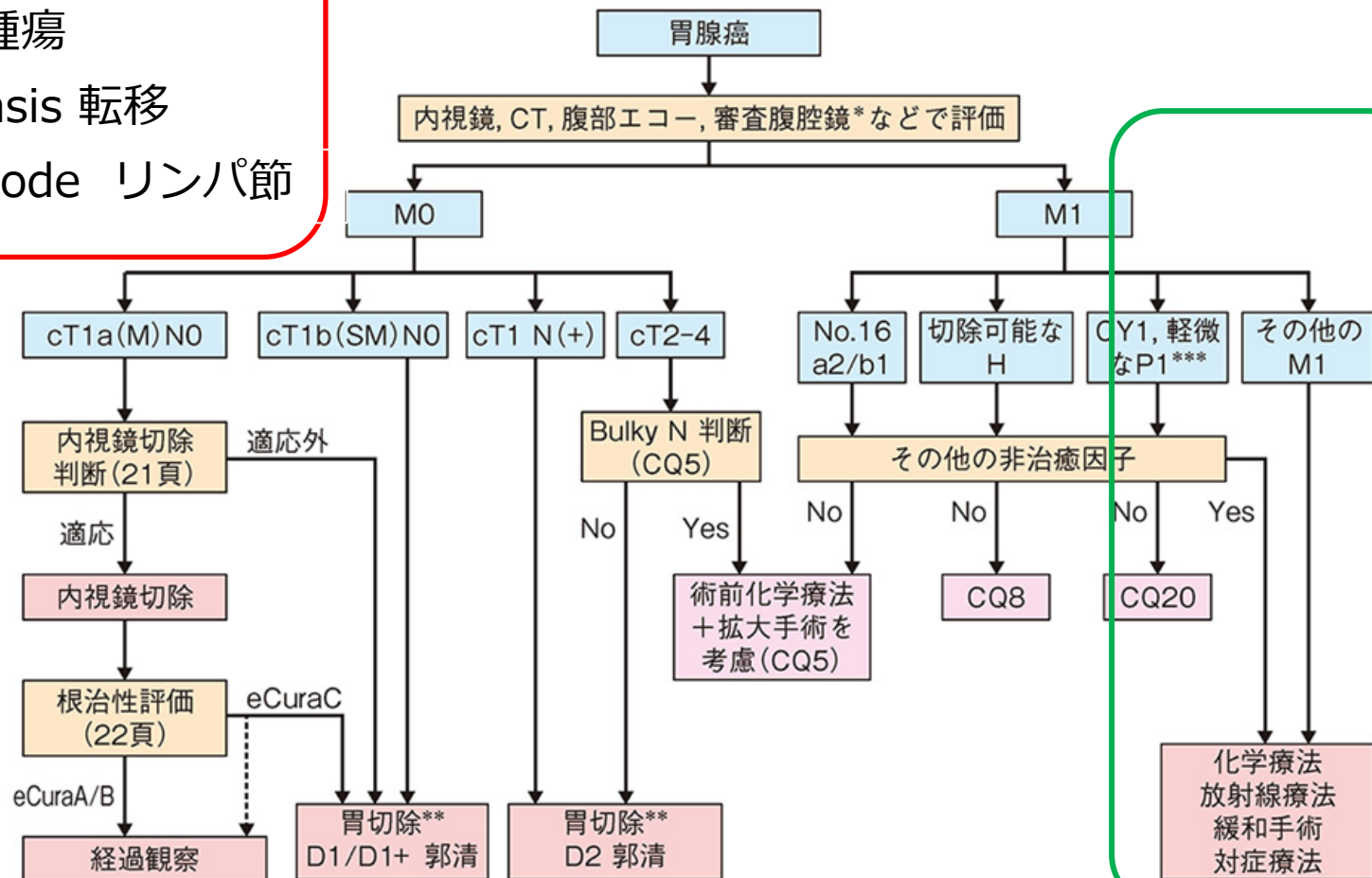


TNM分類

T : tumor 腫瘍

M : metastasis 転移

N : lymph node リンパ節



*審査腹腔鏡の適応についてはCQ10を参照

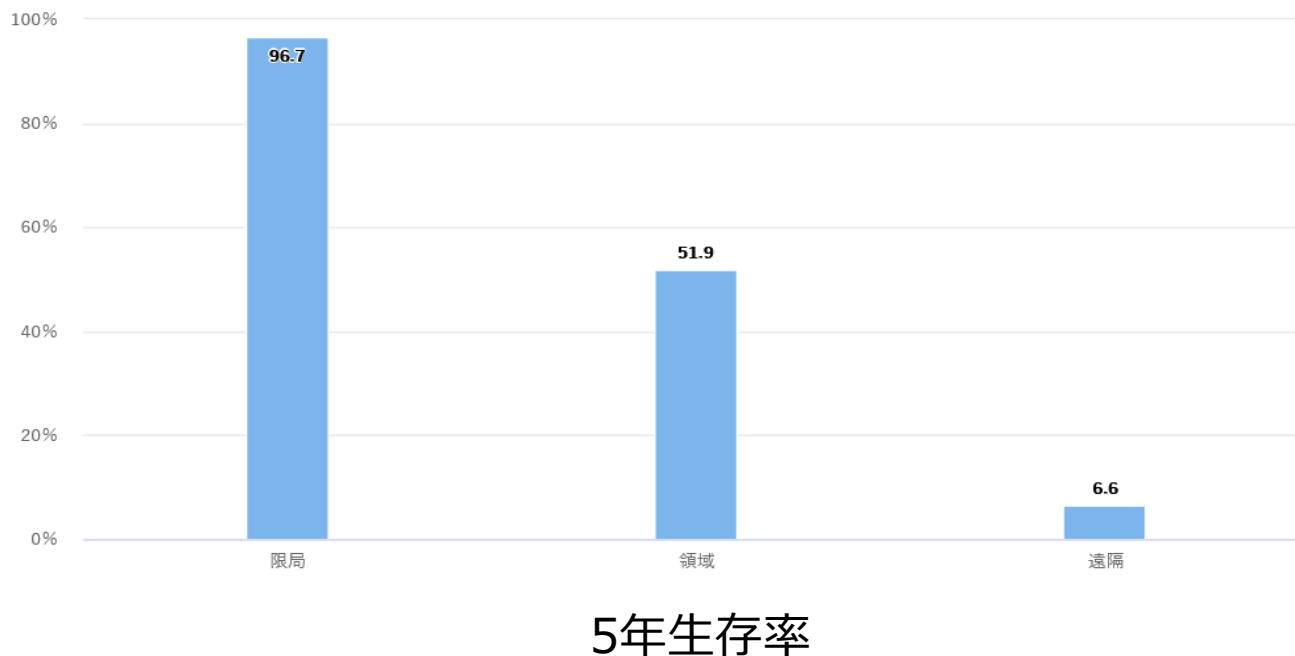
**腹腔鏡手術の適応については17頁参照

***胃周囲や大網の表面などに少数個存在する結節で、胃切除術の際に容易に切除可能なもの

日常診療で推奨される治療選択のアルゴリズム

胃癌 化学療法

- 切除不能進行・再発胃癌に対する化学療法は、最近の進歩により高い腫瘍縮小効果を実現できるようになった。



- 化学療法による完全治癒は現時点では困難

胃癌 化学療法

- 切除不能進行・再発胃癌の生存期間の中央値はおおよそ15カ月。
- 癌の進行に伴う臨床症状の改善や発現時期の遅延および生存期間の延長が治療目標となる。



- PS0～2、主要臓器機能が保たれている、重篤な併存症を有さない、患者本人からのインフォームドコンセントが得られている、などの条件を勘案し、化学療法の導入を決定する。

胃癌の化学療法

化学療法剤（細胞障害性薬剤）

代謝拮抗剤：

- ・ 5-FU
- ・ S-1
- ・ カペシタビン

トポイソメラーゼ阻害剤：

- ・ CPT-11

微小管阻害剤：

- ・ パクリタキセル（PTX）
- ・ ドセタキセル（DTX）

白金化合物：

- ・ シスプラチン（CDDP）
- ・ オキサリプラチン（L-OHP）

分子標的療法剤

抗体薬：

- ・ **トラスツズマブ（Trastuzumab）**

→HER2に対するヒト化モノクローナル抗体。
HER2陽性胃癌に適応。

- ・ **ラムシルマブ（Ramucirumab）**

→VEGFR-2（ヒト血管内皮増殖因子受容体-2）
モノクローナル抗体。

- ・ **ニボルマブ（Nivolumab）**

→ヒト型抗ヒトPD-1（Programmed cell death 1）
モノクローナル抗体。

- ・ **ペンブロリズマブ（Pembrolizumab）**

→ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体。

胃癌 化学療法

胃癌腫瘍部からの生検(または切除標本)組織で

①HER2および

②PDL-1(CPS; combined positive score)の測定

③MSI検査(二次化学療法前)

一次化学療法

HER2陽性

Cape+CDDP+T-mab
S1 + CDDP + T-mab
CapeOX + T-mab
SOX + Tmab

HER2陰性

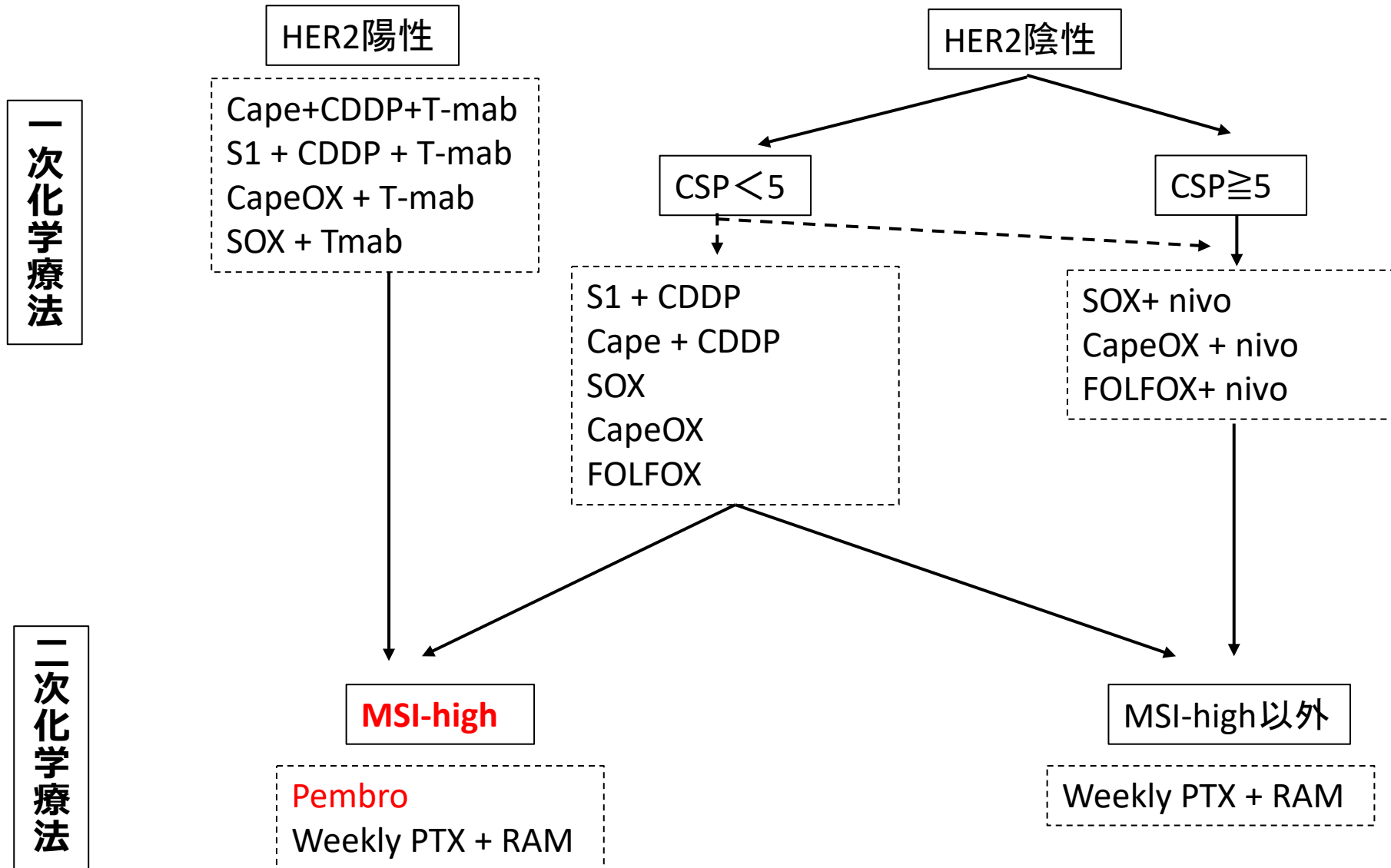
CPS < 5

S1 + CDDP
Cape + CDDP
SOX
CapeOX
FOLFOX

CPS ≥ 5

SOX+ nivo
CapeOX + nivo
FOLFOX+ nivo

胃癌 化学療法



ペムブロリズマブのMSI-H固形がんが国内承認…臓器横断的がん治療が現実に／MSD

提供元：ケアネット



ツイート

いいね！ 2

公開日：2018/12/25

MSD株式会社は、2018年2月12日、抗PD-1抗体ペムブロリズマブ（商品名：キイトルーダ）について、「がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）」の国内製造販売承認事項一部変更の承認を取得した。この適応拡大は医薬品の条件付き早期承認制度の適用を受けていた。

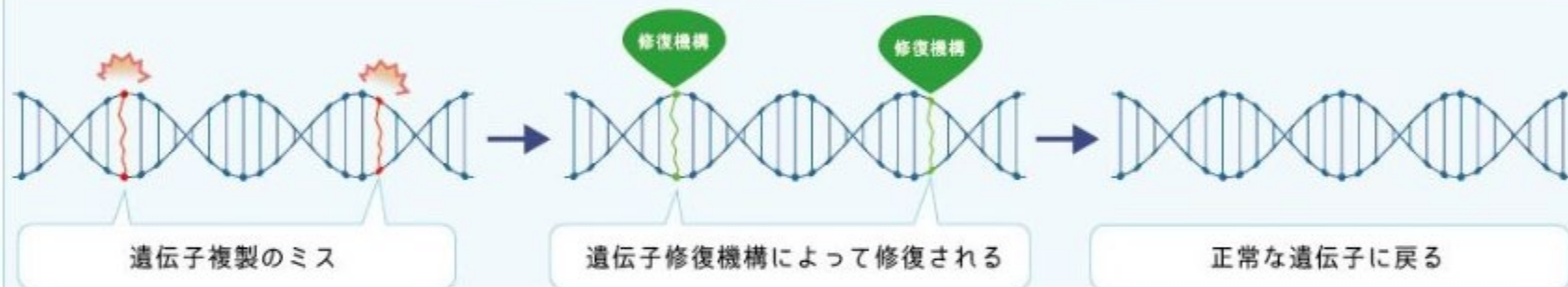


高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）とは、傷ついたDNAを修復する機能が低下していることを示すバイオマーカー。細胞は、DNA複製時に自然に起こる複製ミスを修復する機能をもっているが、この修復機能の低下によって、DNAの繰り返し配列（マイクロサテライト）が正常な細胞と異なる状態になっていることをマイクロサテライト不安定性（MSI）と呼び、このMSIが高頻度に起きている現象を高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）と呼ぶ。

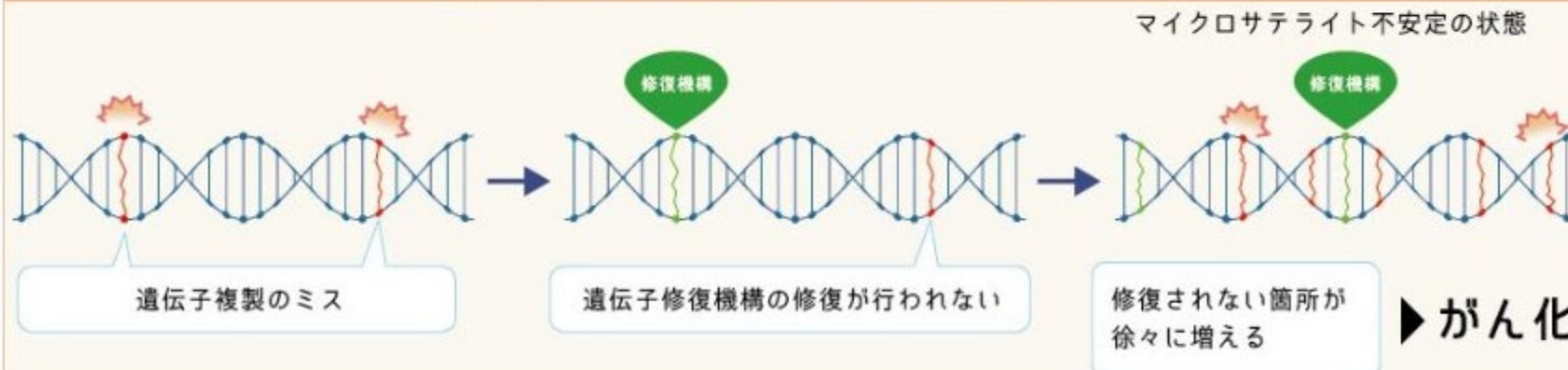
MSI-High固形がんは、大腸がん、胃がんや膵臓がんといった消化器系のがんのほか、子宮内膜がんや卵巣がん、乳がん、前立腺がん、膀胱がん、甲状腺がんなどでも報告されている。大腸がんの約6%、子宮内膜がんの約17%にMSI-High固形がんがみられたとの報告がある。

マイクロサテライト不安定性とは、遺伝子に傷が生じたとき（遺伝子複製のミス）の修復機構に欠損があるため、遺伝子に複数の傷が生じている状態のことを指す。遺伝的にこの修復機構が欠損しているがんの場合をリンチ症候群といい、家族性大腸がんの一種と位置づけられる一方、その他の固形がんでもごく低い割合で存在する。

正常に遺伝子が修復されている状態



遺伝子が正常に修復されずがん化する状態



胃腫瘍

上皮性

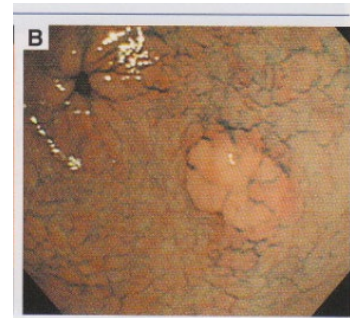
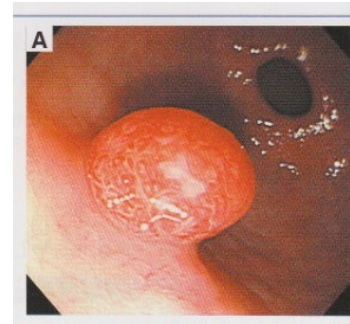
- 胃癌
- 胃ポリープ
 - 1. 胃腺腫、 2. 過形成性ポリープ、 3. 胃底腺ポリープ

非上皮性

- 胃悪性リンパ腫
- GIST (gastrointestinal stromal tumor)

胃ポリープ

- 過形成性ポリープ
H.pyloriによる慢性炎症による過形成。
基本的に経過観察 or HP除菌、出血の原因となる場合には切除することもある。
- 腺腫性ポリープ
病理組織診断でGroup3の病変。 良性・悪性の境界領域の病変。 経過観察or内視鏡的切除
- 胃底腺ポリープ
良性ポリープ。 放置可。



胃腫瘍

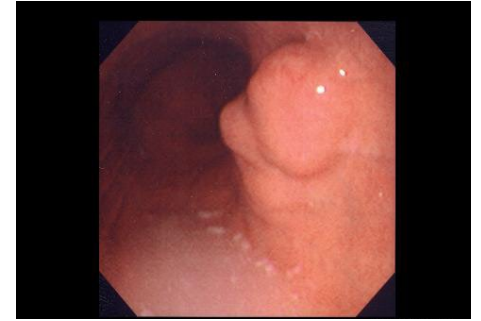
上皮性

- 胃癌
- 胃ポリープ
 1. 胃腺腫、
 2. 過形成性ポリープ、
 3. 胃底腺ポリープ

非上皮性

- 胃悪性リンパ腫
- GIST (gastrointestinal stromal tumor)

胃粘膜下腫瘍（胃SMT submucosal tumor）

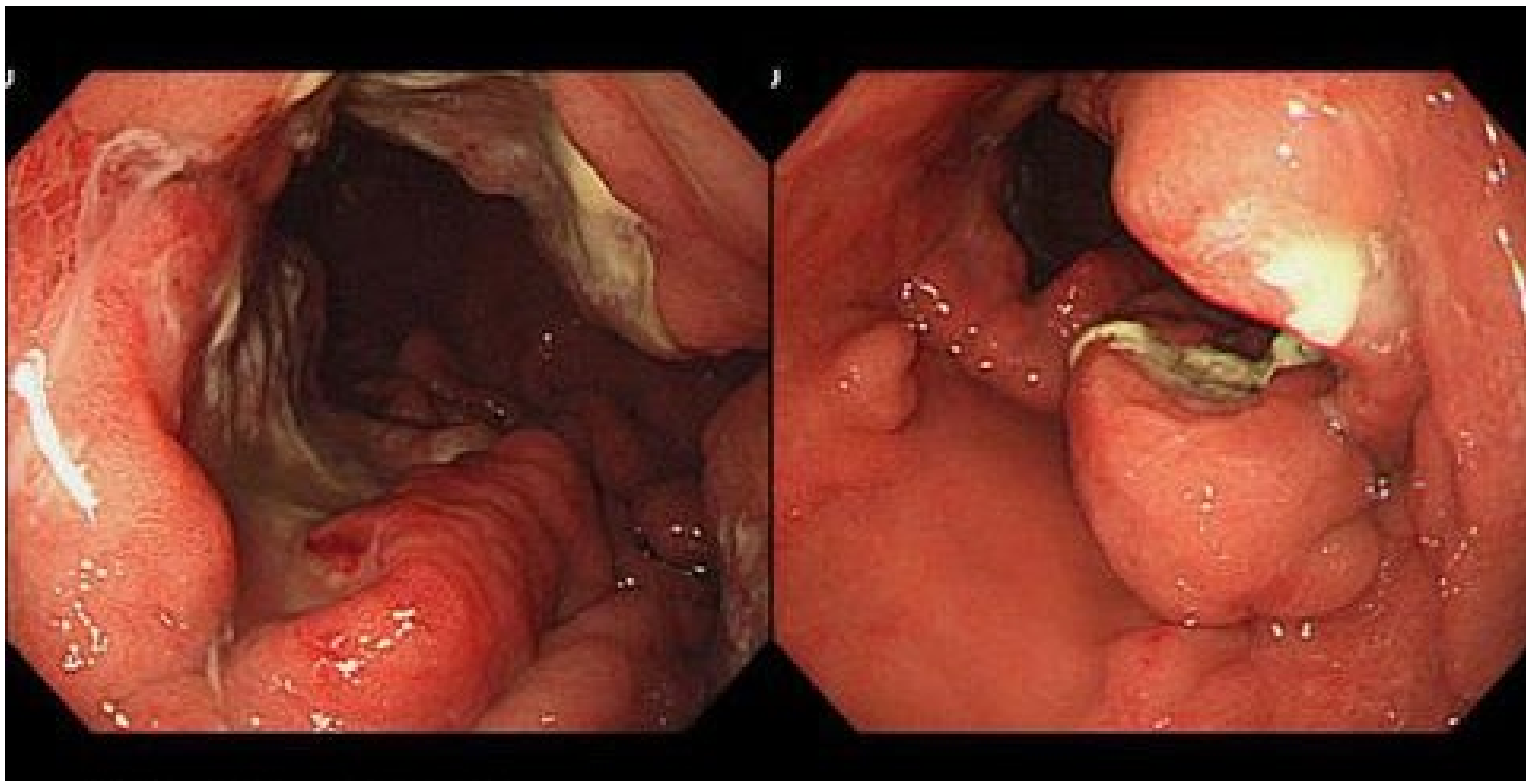


- 主病変が粘膜より下層に存在し、消化管内腔に突出した隆起性病変．臨床的な総称．
- GIST（gastrointestinal stromal tumor）、平滑筋腫、平滑筋肉腫、脂肪腫、迷入瘵など
- EUS（超音波内視鏡検査）が有用．**EUS-FNA**（超音波内視鏡下穿刺細胞診：fine needle aspiration cytology）を行うこともある

胃悪性リンパ腫

- 胃悪性腫瘍の1%程度
- ほとんど非Hodgkin性B細胞リンパ腫
- MALTリンパ腫とDLBCL (diffuse large B cell lymphoma)で大多数を占める
- 治療は*H.pylori*除菌療法、R-CHOP療法、放射線治療

胃悪性リンパ腫 (DLBCL)



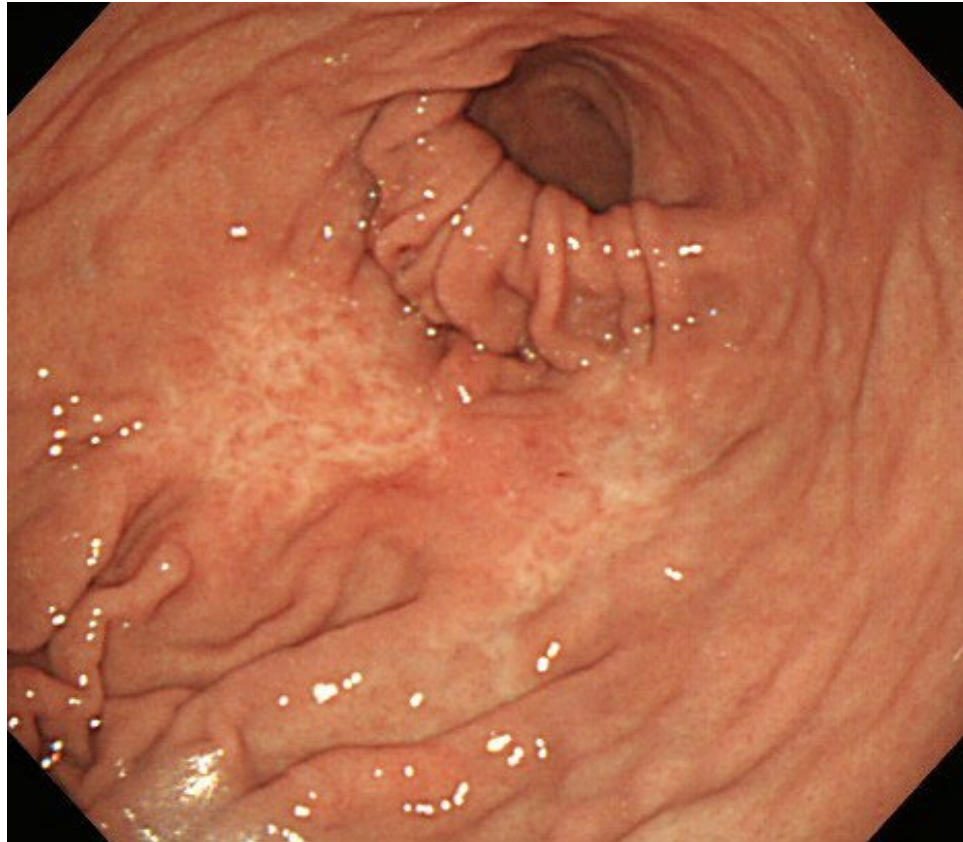
病変の大きさ・深さのわりに壁の伸展性がよく、柔らかい病変。
粘膜下腫瘍様の性質を持つ。周堤隆起は耳介様が特徴的。

胃MALTリンパ腫

(mucosa-associated lymphoid tissue)

- 悪性リンパ腫に含まれる
- 粘膜関連リンパ組織 (MALT)を発生母地とする低悪性度リンパ腫
- 発症・増殖に*H.pylori*が深く関与
- 治療：限局期は*H.pylori*除菌．進行期はリツキシマブ併用CHOP療法 (R-CHOP)などの多剤併用化学療法

胃MALTリンパ腫



境界が不明瞭な褪色调の病変。多彩な所見を呈する。

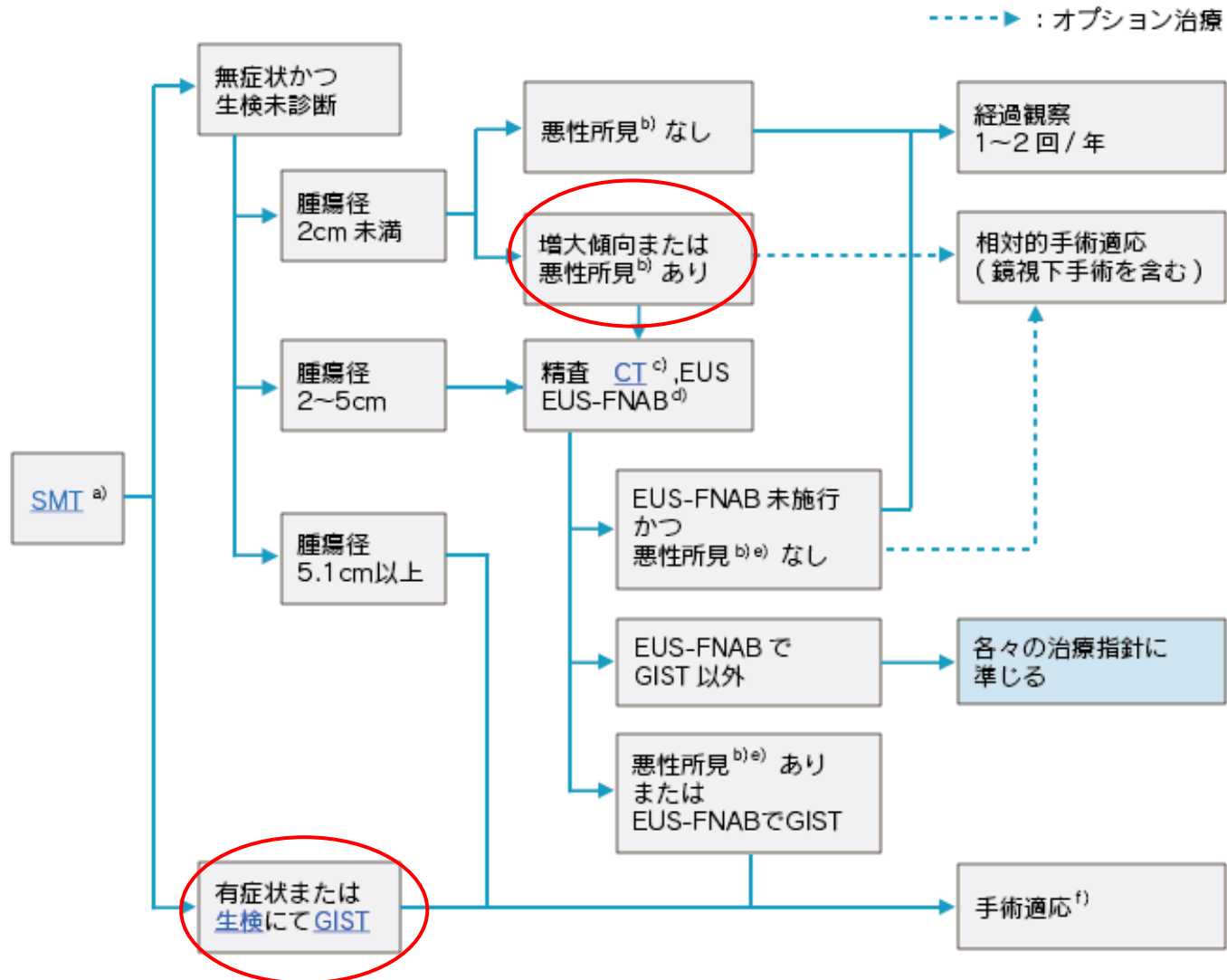
GIST

(gastrointestinal stromal tumor)

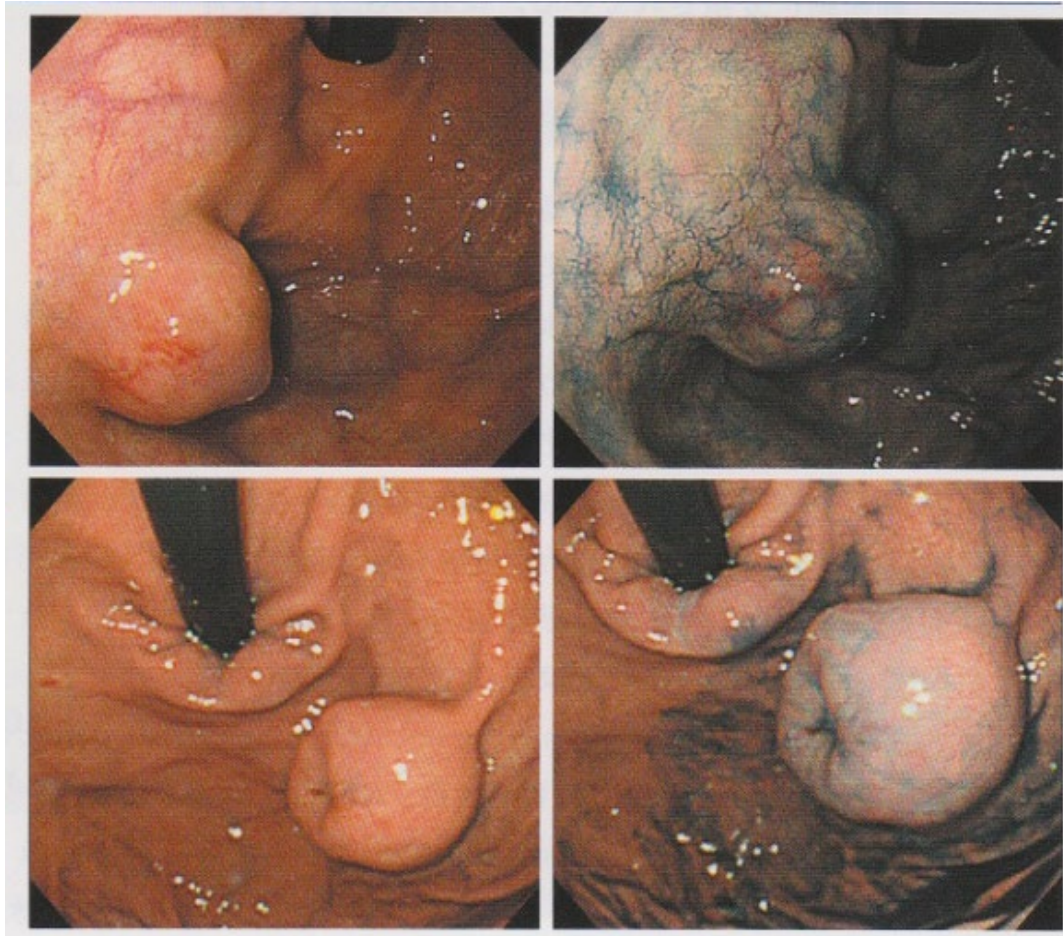
- 粘膜下腫瘍の代表的疾患、間葉系腫瘍
- 消化管ペースメーカー細胞であるCajalの介在細胞由来
- 免疫組織染色でKIT陽性、CD34陽性
- 2cm未満は経過観察. 2-5cmで悪性所見がなければ経過観察or局所切除. 5cm以上ならば手術. 切除不能の場合はチロシンキナーゼ阻害剤（イマチニブ）.

GIST

(gastrointestinal stromal tumor)



GIST



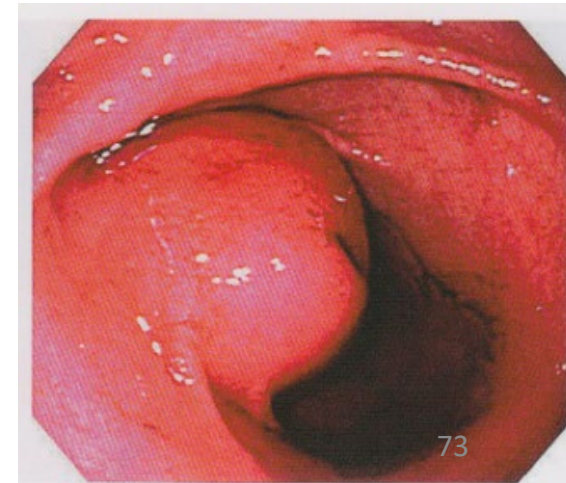
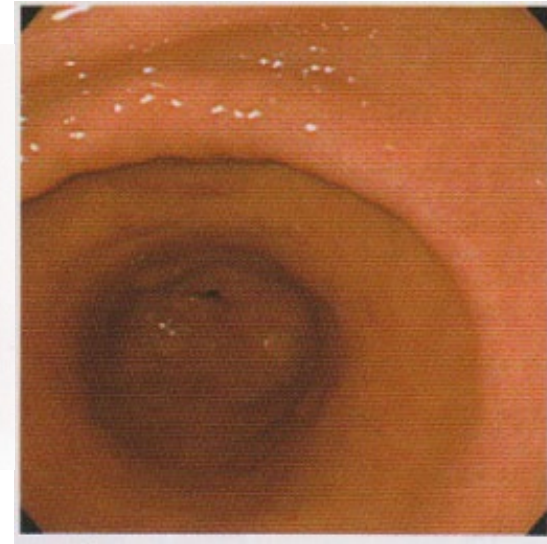
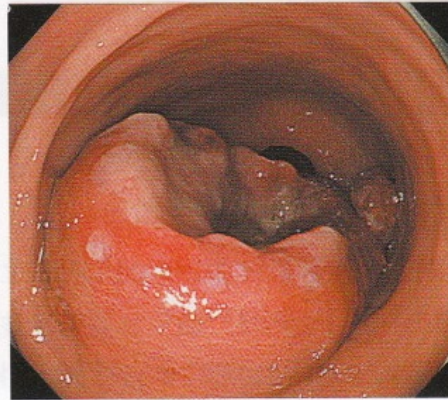
Bridging foldや頂部にdelle（腫瘍頂部のくぼみ）を認める

医師国家試験過去問 5

45歳の女性。上腹部不快感を訴えて来院した。最近3カ月で2kgの体重減少がある。身長154cm、体重43kg。表在リンパ節は触知しない。眼瞼結膜に軽度貧血を認める。心窩部に軽度の圧痛がある。血液所見：赤血球340万、Hb11.4g/dl、Ht33%、白血球4500、血小板21万。上部消化管造影写真(A)と胃内視鏡写真(B)とを別に示す。最も考えられるのはどれか。

- a 急性胃炎
- b 胃潰瘍
- c II c型早期胃癌
- d 4型進行胃癌
- e 胃肉腫

→ GIST



実際の診察の流れ

症状・臨床所見

早期胃癌は症状が現れないことが多い。

進行すると、黒色便、運動時の息切れ、易疲労感などの貧血症状が現れることがある。

進行した胃癌では腫瘍の増大に伴い腹部にしこりを触れたり、体重減少、食物の通過障害、閉塞症状が現れることがある。



検査・診断・分類

検査はまず胃内視鏡、胃X線検査を行う。

生検 (biopsy) で癌細胞の存在が確認できれば確定。

他にCT、超音波検査などで他臓器への浸潤・転移などを診断する。



治療

実際の臨床現場での症例

症例 60歳代 男性

紹介状

平成〇〇年9月下旬

主訴：心窩部痛、食欲不振、貧血

高血圧などで当院通院加療中の患者様です。1ヶ月ほど前から心窩部痛あり、食欲が低下していたことです。9月から食欲不振が続くため、9月中旬当院受診。眼瞼結膜貧血があり、血液検査を施行したところHb7.7g/dlと高度の貧血を認めました。症状強いため、早急に治療が必要と考え紹介させていただきました。

当院での処方法は・・・

上記の方をご紹介申し上げます。御多用中恐れ入りますが、宜しくお願い申し上げます。

血液検査

血算;

白血球7400/ μ l(好中球 42.1%, 好酸球 3.1%, 好塩基球 0.2%, リンパ球 45.2%, 単球 9.4%),

Hb 7.3g/dl (正常値 13~17)

plt 35.8万

生化学 ;

総蛋白 5.8g/dl,

アルブミン 3.0g/dl,

総ビリルビン 0.2mg/dl,

AST 24IU/l, ALT 28IU/l, LDH 220IU/l, ALP 273IU/l,

TC 120mg/dl, CRP 0.56mg/dl,

尿素窒素 9mg/dl, クレアチニン 0.7mg/dl,

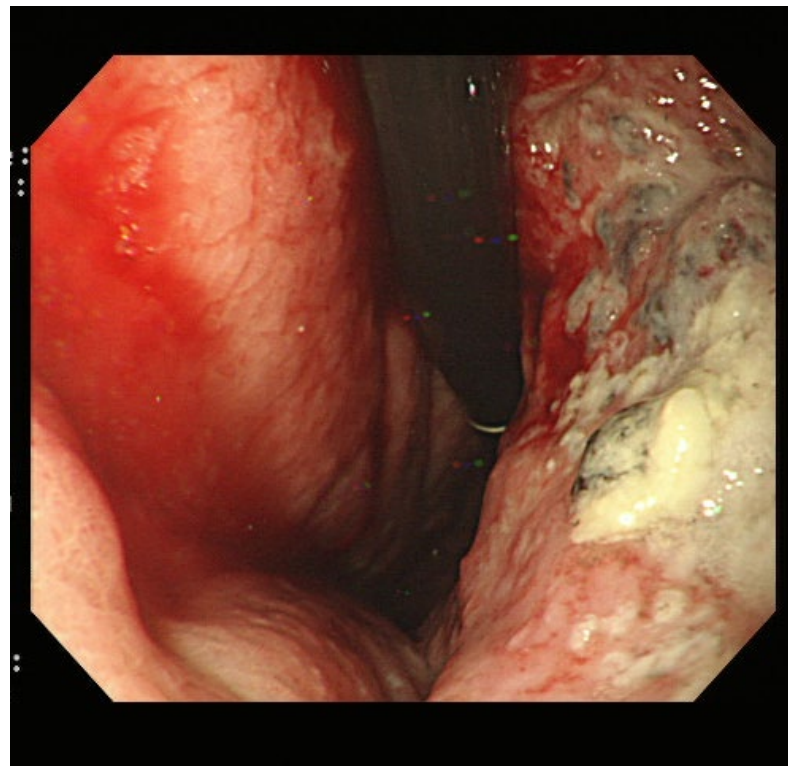
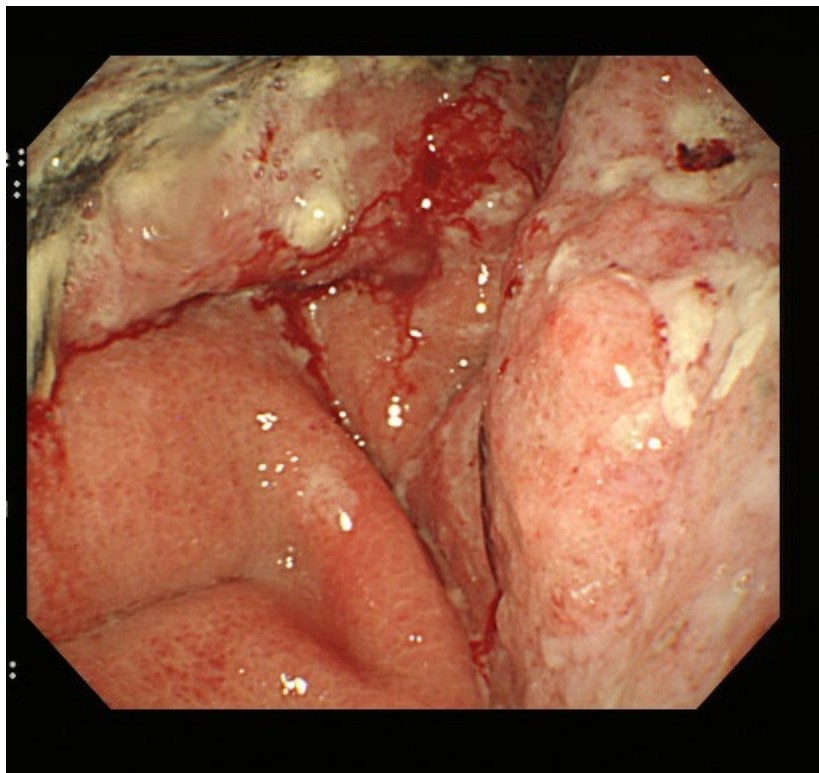
Na 141mEq/l, K 4.0mEq/l, Cl 108mEq/l,

血糖 96mg/dl

腫瘍マーカー ; CEA 8.0ng/ml (正常値 5以下)

CA19-9 627.0U/ml (正常値 37以下)

胃内視鏡

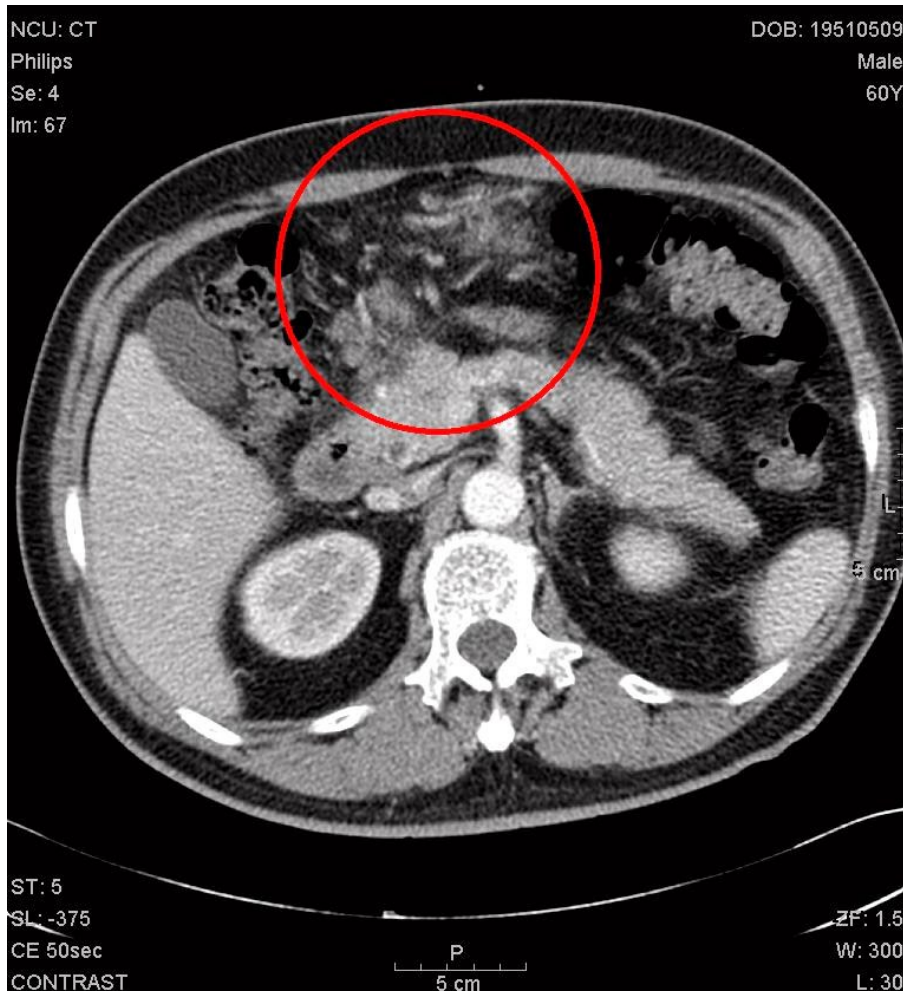


病理組織檢查結果： Group5、 中～低分化腺癌、HER2(1+)

消化管造影



CT

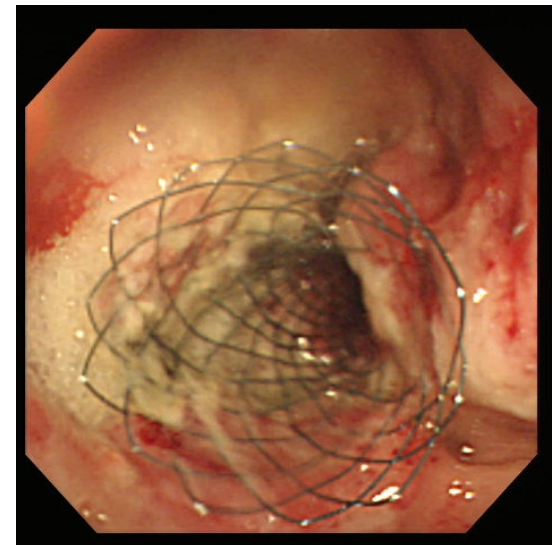


診断・経過

診断：胃癌、 腹膜播種
stage IV



経過：内視鏡的ステント留置術施行
化学療法（S-1+CDDP）を施行



お疲れさまでした。